

SELF EMPOWERMENT KUNCI MENUJU KESEHATAN OPTIMAL

Rizeki Dwi Fibriansari • Nurfika Asmaningrum
Anggia Astuti



SELF EMPOWERMENT: KUNCI MENUJU KESEHATAN OPTIMAL

Penulis:

Ns. Rizeki Dwi Fibriansari, S.Kep., M.Kep.

Ns. Nurfika Asmaningrum, S.Kep., M.Kep., Ph.D.

Ns. Anggia Astuti, S.Kp., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

SELF EMPOWERMENT: KUNCI MENUJU KESEHATAN OPTIMAL

Penulis: Ns. Rizeki Dwi Fibriansari, S.Kep., M.Kep.
Ns. Nurfika Asmaningrum, S.Kep., M.Kep., Ph.D.
Ns. Anggia Astuti, S.Kp., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhammad Ilham S.Pd.

ISBN: 978-634-7139-43-6

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Kesehatan merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia dan erat kaitannya dengan gaya hidup serta indeks massa tubuh. Model *health self-empowerment* menjadi inovasi penting, terutama di area pertanian, di mana masyarakat menghadapi tantangan unik terkait pekerjaan fisik tinggi dan kurangnya akses terhadap informasi kesehatan. Buku ini mengulas tentang pemberdayaan masyarakat agrikultural untuk mencapai kesehatan yang optimal melalui gaya hidup sehat. Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari dalam buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran terhadap penyempurnaan buku ini penulis harapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum untuk mengintegrasikan pendekatan holistik dalam mencegah penyakit tidak menular dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat serta produktif.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
 BAB 2 TEORI DAN KONSEP DASAR HEALTH SELF-EMPOWERMENT	 5
A. Definisi Health Self-Empowerment.....	5
B. Landasan Teori Health <i>Self-Empowerment</i>	7
C. <i>Health Self-Empowerment</i> Memodifikasi Gaya Hidup.....	11
 BAB 3 GAYA HIDUP SEHAT DI MASYARAKAT AGRIKULTURAL.....	 17
A. Kondisi Kesehatan Masyarakat di Area Agrikultural.....	17
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup Sehat di Wilayah Agrikultural.....	20
C. Perbedaan Gaya Hidup antara Masyarakat Agrikultural dan Perkotaan	23
 BAB 4 PENERAPAN MODEL <i>HEALTH SELF-EMPOWERMENT</i> DALAM MODIFIKASI GAYA HIDUP SEHAT.....	 27
A. Komponen Utama Model <i>Health Self-Empowerment</i>	27
B. Strategi Penerapan <i>Health Self-Empowerment</i> untuk Masyarakat Agrikultural	31

C. Manfaat <i>Health Self-Empowerment</i> , (HSE) dalam Pengelolaan Kesehatan Pribadi dan Komunitas.....	46
--	----

BAB 5 HEALTH SELF-EMPOWERMENT DAN PENGELOLAAN *BODY MASS INDEX* (BMI)51

A. Peran <i>Body Mass Index</i> (BMI) sebagai Indikator Kesehatan	51
B. Penerapan <i>Health Self-Empowerment</i> (HSE) untuk Manajemen Berat Badan dan Keseimbangan Gizi.....	55
C. Hubungan Antara Gaya Hidup Sehat dan Pengendalian BMI di Masyarakat Pertanian.....	57

BAB 6 INTERVENSI *HEALTH SELF-EMPOWERMENT* UNTUK MASYARAKAT AGRIKULTURAL.....61

A. Pendekatan Partisipatif dalam Program <i>Health Self-Empowerment</i> (HSE)	61
B. Keterlibatan Tokoh Masyarakat, Penyuluh Pertanian, dan Pemerintah Lokal.....	64
C. Implementasi Teknologi Informasi.....	69

BAB 7 IMPLEMENTASI *HEALTH SELF-EMPOWERMENT* DI AREA PERTANIAN.....73

A. Intervensi <i>Health Self-Empowerment</i> (HSE) dalam Masyarakat Agrikultural.....	73
B. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Model <i>Health Self-Empowerment</i> (HSE).....	75

BAB 8 PENUTUP.....81

DAFTAR PUSTAKA.....	85
GLOSARIUM	93
PROFIL PENULIS.....	95

BAB 1

PENDAHULUAN

Health Self-Empowerment (HSE) atau pemberdayaan kesehatan diri merupakan konsep yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran individu dalam menjaga kesehatan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap informasi kesehatan semakin terbuka lebar. Namun, akses informasi yang luas ini belum tentu efektif tanpa pemahaman dan kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran *Health Self-Empowerment* (HSE) menjadi signifikan. *Health Self-Empowerment* (HSE) mendorong individu untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, serta rasa percaya diri dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kesehatan mereka sendiri. Dengan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kesehatan pribadi dan komunitasnya. *Health Self-Empowerment* (HSE) juga memberikan panduan bagi individu dalam meminimalisasi risiko penyakit serta mengadopsi gaya hidup sehat secara mandiri.

Konsep *Health Self-Empowerment* (HSE) berakar pada beberapa faktor penting, termasuk meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, yang sangat terkait dengan gaya hidup individu. PTM sering kali dipicu oleh faktor risiko seperti pola makan yang tidak sehat,

kurangnya aktivitas fisik, dan merokok. Masyarakat seringkali belum sepenuhnya menyadari bahwa banyak penyakit dapat dicegah dengan perubahan perilaku sederhana. Oleh karena itu, *Health Self-Empowerment* (HSE) tidak hanya memberikan panduan tentang pengetahuan kesehatan tetapi juga memberdayakan individu untuk mengubah gaya hidup dan pola pikir mereka. Dengan demikian, *Health Self-Empowerment* (HSE) bukan sekadar pendekatan edukasi, tetapi juga bentuk pencerahan bagi setiap individu untuk menyadari bahwa mereka memiliki kontrol terhadap kesehatan mereka sendiri.

Di dalam konteks masyarakat agrikultural, *Health Self-Empowerment* (HSE) memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat agrikultural seringkali bekerja di lingkungan yang penuh risiko, seperti paparan pestisida, kondisi cuaca ekstrem, serta beban fisik yang berat. Selain itu, akses mereka terhadap fasilitas kesehatan sering kali terbatas akibat jarak geografis atau infrastruktur yang belum memadai. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat agrikultural sering kali mengharuskan mereka untuk bekerja lebih keras dengan sumber daya yang minim, sehingga perhatian terhadap kesehatan pribadi cenderung diabaikan. Dalam kondisi ini, *Health Self-Empowerment* (HSE) menjadi sangat relevan sebagai sarana yang bisa membantu masyarakat agrikultural mengenali risiko kesehatan dan mengelola kesejahteraan mereka secara mandiri. Dengan mengembangkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, masyarakat agrikultural dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan dan meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Health Self-Empowerment (HSE) memberikan wawasan tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja. Masyarakat agrikultural, misalnya, seringkali bekerja di lingkungan yang rentan terhadap pencemaran, baik dari bahan kimia pertanian maupun dari limbah pertanian itu sendiri. Melalui *Health Self-Empowerment* (HSE), mereka dapat lebih memahami cara mengurangi paparan terhadap zat berbahaya serta meningkatkan kualitas kesehatan dengan metode-metode sederhana, seperti penggunaan alat pelindung diri, menjaga kebersihan diri, serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan kerja. Dengan demikian, *Health Self-Empowerment* (HSE) tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga dapat meningkatkan kondisi kesehatan secara kolektif di lingkungan kerja agrikultural.

Buku ini ditujukan untuk memberikan panduan praktis kepada masyarakat agrikultural dalam mengaplikasikan konsep *Health Self-Empowerment* (HSE). Tujuan utama buku ini adalah untuk memberdayakan masyarakat agrikultural agar lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit, tips kesehatan yang sesuai dengan kondisi kerja agrikultural, serta panduan untuk mengakses layanan kesehatan yang tersedia di komunitas mereka. Sasaran utama dari buku ini adalah petani, pekerja perkebunan, dan masyarakat pedesaan lainnya yang terlibat dalam sektor agrikultural, yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal akses kesehatan.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan praktis agar mudah dipahami oleh masyarakat agrikultural. Dengan adanya buku ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri dan mampu mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi dalam lingkungan agrikultural. Buku ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat agrikultural melalui penerapan prinsip *Health Self-Empowerment* (HSE), sehingga mereka dapat terus bekerja secara produktif dan sehat.

BAB 2

TEORI DAN KONSEP DASAR HEALTH SELF-EMPOWERMENT

A. Definisi Health Self-Empowerment

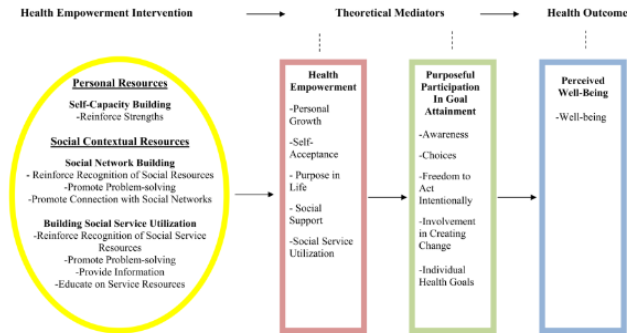
Health Self-Empowerment (HSE) atau pemberdayaan kesehatan diri adalah konsep yang menitikberatkan pada kemampuan individu untuk mengelola kesehatannya sendiri melalui pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kesehatan (Tucker et al., 2018). Secara teori, *Health Self-Empowerment* (HSE) didasarkan pada prinsip bahwa individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memelihara kesehatannya dengan pendekatan yang partisipatif dan mandiri. Konsep ini muncul dari teori psikologi kesehatan dan sosial yang menekankan pentingnya *self-efficacy* atau keyakinan diri dalam menentukan perilaku sehat seseorang. Dalam konteks *Health Self-Empowerment* (HSE), *self-efficacy* menjadi pondasi utama yang membantu individu percaya diri bahwa mereka mampu mengatasi tantangan kesehatan yang dihadapi, membuat keputusan sehat, dan mengadopsi gaya hidup yang mendukung kesejahteraan mereka. Menurut Pender (2019) dalam teori *Health Promotion Model* (HPM), kesehatan seseorang dipengaruhi keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengambil langkah-langkah tertentu menuju pola hidup sehat. Dengan demikian,

Health Self-Empowerment (HSE) mengarah pada pemberdayaan individu dalam membuat keputusan yang efektif dan positif bagi kesehatan jangka panjang.

Health Self-Empowerment (HSE) merupakan hasil dari perkembangan berbagai teori yang menggabungkan pendekatan medis dan sosial. Pada awalnya, pemberdayaan kesehatan diri mulai berkembang sebagai respons terhadap perubahan dalam model kesehatan masyarakat yang lebih menekankan keterlibatan individu daripada sekadar intervensi medis (Zimmerman, 2020). Paradigma ini muncul ketika para peneliti dan praktisi kesehatan mulai menyadari bahwa keberhasilan kesehatan masyarakat tidak dapat dicapai sepenuhnya hanya dengan meningkatkan akses fasilitas kesehatan. Sebaliknya, individu perlu memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi kesehatannya sendiri, mengenali faktor risiko, dan mampu mengambil langkah-langkah preventif atau tindakan kesehatan yang sesuai. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh perkembangan pendekatan *Behavioral Theory*, yang menyatakan bahwa perilaku individu merupakan hasil dari keyakinan, lingkungan, serta faktor personal lainnya (Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control*, 2021). Seiring waktu, pendekatan behavioral ini diperluas untuk meliputi aspek pemberdayaan, yang secara khusus mengakui pentingnya memberdayakan individu untuk memiliki kontrol terhadap kesehatan mereka.

B. Landasan Teori Health *Self-Empowerment*

Dalam perkembangannya, *Health Self-Empowerment* (HSE) menjadi komponen penting dalam promosi kesehatan di masyarakat, terutama dengan meningkatnya kesadaran tentang peran individu dalam menentukan kesehatannya sendiri. Menurut sebuah studi oleh Whitehead dan Dahlgren (2020), pemberdayaan diri dalam konteks kesehatan menjadi semakin relevan seiring dengan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) yang membutuhkan perubahan gaya hidup jangka panjang, seperti pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur. Melalui *Health Self-Empowerment* (HSE), individu diharapkan dapat mengendalikan faktor risiko tersebut dan berperan aktif dalam pencegahan penyakit. Bahkan dalam pendekatan kesehatan mental, pemberdayaan diri dianggap memiliki efek yang signifikan, terutama dalam mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan *coping mechanism* seseorang. Ketika individu merasa memiliki kendali terhadap kesehatannya, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mempraktikkan perilaku sehat dan bertahan dalam menghadapi tantangan kesehatan yang dihadapi (Wippold & Frary, 2022).



Gambar 2.1: Kerangka Teori *Health Self-Empowerment* (n, Eunsung Mouradian & Tang et al., 2008)

Health Self-Empowerment (HSE) juga dipengaruhi oleh konsep *Patient Empowerment* yang berkembang pesat pada dekade terakhir. *Patient Empowerment* pada dasarnya mengajak pasien untuk aktif dalam setiap tahap perawatan kesehatan yang mereka jalani (Bravo, et al., 2021). *Health Self-Empowerment* (HSE) melangkah jauh dengan memberdayakan individu dalam tindakan preventif, bukan hanya pada saat perawatan atau pengobatan. Misalnya, seseorang yang mengadopsi *Health Self-Empowerment* (HSE) akan mulai menerapkan gaya hidup sehat bahkan sebelum muncul keluhan kesehatan, karena dia memahami bahwa pola hidup sehat dapat mengurangi risiko penyakit di masa depan. Penerapan *Health Self-Empowerment* (HSE) tidak hanya terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup perubahan gaya hidup secara menyeluruh, termasuk pola makan, aktivitas fisik, serta manajemen stres dan emosi. Berdasarkan penelitian oleh Fumagalli (2020), orang yang memiliki tingkat *self-empowerment* yang tinggi menunjukkan kualitas

hidup yang lebih baik dan memiliki sikap yang lebih positif dalam menghadapi penyakit.

Dalam ranah teori psikologi kesehatan, *Health Self-Empowerment* (HSE) juga terkait erat dengan pendekatan *Health Belief Model* (HBM) yang menjelaskan bahwa tindakan kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap kerentanan (*susceptibility*) dan keparahan (*severity*) suatu penyakit, serta keuntungan dan hambatan dalam melakukan tindakan pencegahan (Rosenstock, Strecher, & Becker, 2020). *Health Self-Empowerment* (HSE) mendorong individu untuk memahami pentingnya tindakan pencegahan dengan membangun kepercayaan diri untuk melakukannya secara mandiri. Dengan mengombinasikan *Health Belief Model* (HBM), *Health Self-Empowerment* (HSE) juga melibatkan proses evaluasi risiko secara mandiri, sehingga individu dapat menentukan sendiri prioritas kesehatannya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar.

Pentingnya *Health Self-Empowerment* (HSE) juga terlihat dalam pendekatan kesehatan masyarakat yang menekankan pentingnya peran aktif individu untuk kesehatan komunitasnya. Di banyak negara, pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai program kesehatan, seperti kampanye pencegahan merokok, peningkatan kesadaran tentang gizi, dan promosi aktivitas fisik. Menurut Nilsen (2019), program-program yang menekankan pada pemberdayaan diri masyarakat ini telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan mengurangi risiko kesehatan secara signifikan. Di

masyarakat agrikultural, misalnya, konsep *Health Self-Empowerment* (HSE) membantu mereka lebih sadar akan risiko-risiko yang timbul dari lingkungan kerja, seperti paparan pestisida dan risiko cedera fisik. Dengan kesadaran ini, mereka dapat mengimplementasikan tindakan pencegahan sederhana, seperti menggunakan alat pelindung diri atau melakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Davis dan Jones (2021), program-program berbasis *Health Self-Empowerment* (HSE) dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agrikultural dan mengurangi biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah.

Sebagai konsep yang berorientasi pada individu, *Health Self-Empowerment* (HSE) juga mendapat dukungan dari teknologi informasi. Dengan kemajuan aplikasi kesehatan dan *telemedicine*, individu kini memiliki akses lebih mudah untuk memantau kondisi kesehatannya sendiri. Menurut penelitian dari Lupton (2021), pemanfaatan teknologi dalam *Health Self-Empowerment* (HSE) memungkinkan individu untuk memonitor data kesehatan pribadi, seperti tekanan darah, kadar gula, atau kualitas tidur, yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait gaya hidup sehat. Teknologi ini juga memudahkan akses terhadap informasi kesehatan yang relevan, sehingga individu dapat membuat keputusan yang lebih berdasarkan bukti ilmiah. Dengan adanya aplikasi kesehatan yang dapat diakses kapan saja, *Health Self-Empowerment* (HSE)

menjadi lebih praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga, landasan teori *Health Self-Empowerment* (HSE) didukung oleh berbagai model dalam psikologi kesehatan dan sosial yang menekankan pada kontrol diri, efikasi diri, dan partisipasi aktif individu dalam menjaga kesehatan. Teori-teori ini, seperti *Social Cognitive Theory*, *Health Belief Model*, dan *Theory of Planned Behavior*, membentuk kerangka bagi individu untuk memahami pentingnya berperilaku sehat, serta memberikan strategi untuk mengatasi hambatan dalam mempertahankan gaya hidup sehat. Dengan adanya dukungan dari teknologi, *Health Self-Empowerment* (HSE) juga semakin relevan dalam masyarakat modern, memungkinkan individu untuk mengakses informasi kesehatan secara mandiri dan membuat keputusan kesehatan yang lebih baik. Pemberdayaan dalam kesehatan bukan hanya membangun kemampuan untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat kesiapan mental untuk menghadapi tantangan kesehatan jangka panjang.

C. *Health Self-Empowerment* Memodifikasi Gaya Hidup

Dalam kerangka *Health Self-Empowerment* (HSE), individu didorong untuk menjadi pengambil keputusan utama dalam perawatan kesehatan, daripada bergantung sepenuhnya pada profesional kesehatan. Menurut Lazarus dan Folkman (1984), pengambilan keputusan dan kemampuan mengatasi stres adalah dua komponen kunci dalam

pemberdayaan diri, terutama terkait kesehatan. Individu yang memiliki kemampuan *Health Self-Empowerment* (HSE) dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih baik, seperti memilih pola makan yang sehat, menjalankan aktivitas fisik secara teratur, atau mengelola stres melalui teknik-teknik relaksasi. Dengan meningkatkan *Health Self-Empowerment* (HSE), individu tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka tetapi juga mengurangi risiko terkena penyakit serius, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan hipertensi, yang kerap dikaitkan dengan gaya hidup tidak sehat.

Aspek penting lain dari *Health Self-Empowerment* (HSE) merupakan kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan kesehatan yang realistis. Hal ini terkait erat dengan teori *Self-Determination* (Ryan & Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, 2000), yang menyatakan bahwa individu cenderung lebih termotivasi secara intrinsik ketika memiliki kontrol atas tujuan dan cara mencapainya. Dalam konteks kesehatan, seseorang yang memiliki *Health Self-Empowerment* (HSE) yang tinggi akan lebih mampu untuk menetapkan tujuan kesehatan yang realistis, seperti meningkatkan aktivitas fisik atau menurunkan berat badan secara bertahap, tanpa bergantung pada tekanan eksternal. Tujuan yang jelas, dengan strategi yang direncanakan, membantu individu merancang pendekatan yang dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Health Self-Empowerment (HSE) berkaitan dengan tingkat literasi kesehatan, yaitu kemampuan untuk memahami informasi kesehatan dan menggunakannya secara efektif. Tingkat literasi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk lebih paham dalam memilih sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini sangat penting, terutama di era digital saat ini, di mana informasi kesehatan mudah diakses namun sering kali tidak diverifikasi atau bahkan menyesatkan. Menurut penelitian oleh Nutbeam (2008), literasi kesehatan yang baik membantu seseorang untuk berinteraksi dengan layanan kesehatan dengan lebih efektif, memahami risiko kesehatan mereka sendiri, serta memilih perawatan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan literasi kesehatan yang kuat, *Health Self-Empowerment* (HSE) juga meningkatkan kemampuan individu untuk berkolaborasi dengan profesional kesehatan dalam menyusun rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka.

Health Self-Empowerment (HSE) juga memainkan peran penting dalam manajemen penyakit kronis. Dalam kasus-kasus penyakit kronis seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, individu perlu memantau kondisi mereka secara mandiri dan membuat keputusan harian mengenai pola makan, aktivitas fisik, serta konsumsi obat-obatan. Dengan *Health Self-Empowerment* (HSE), individu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang penyakit mereka dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka dalam

jangka panjang. Hal ini sangat penting karena penyakit kronis memerlukan pengelolaan yang berkesinambungan, yang tidak mungkin dicapai hanya melalui kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan (Fibriansari, 2021).

Di samping itu, *Health Self-Empowerment* (HSE) berperan penting dalam pengelolaan stres, yang merupakan faktor risiko besar bagi banyak masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Kemampuan untuk mengatasi stres secara efektif, misalnya melalui *mindfulness*, meditasi, atau latihan pernapasan, menjadi aspek penting dalam *Health Self-Empowerment* (HSE). Individu yang mampu mengelola stres dengan baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih jarang mengalami gangguan seperti kecemasan atau depresi. Dalam jangka panjang, kemampuan ini juga mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan stres kronis, seperti penyakit jantung dan gangguan pencernaan (Sapolsky, 2004). Dengan *Health Self-Empowerment* (HSE) yang kuat, seseorang dapat lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta lebih tangguh dalam menghadapi situasi sulit tanpa mengorbankan kesehatan mereka.

Lebih jauh, *Health Self-Empowerment* (HSE) mendukung pengembangan pola pikir positif, yang penting dalam menciptakan kebiasaan sehat yang bertahan lama. Dweck (2006) memperkenalkan konsep *growth mindset*, yaitu pola pikir yang berfokus pada perkembangan dan pembelajaran. Individu yang memiliki *growth mindset* dalam kesehatan akan melihat perubahan gaya hidup bukan

sebagai sesuatu yang sulit atau memerlukan pengorbanan besar, tetapi sebagai proses bertahap yang membawa manfaat jangka panjang. Hal ini meningkatkan motivasi individu untuk terus berusaha dalam mencapai tujuan kesehatan mereka, meskipun menghadapi tantangan atau kemunduran.

Dengan memberdayakan individu untuk mengelola kesehatannya sendiri, *Health Self-Empowerment* (HSE) tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan formal yang sering kali memerlukan biaya tinggi. Penerapan *Health Self-Empowerment* (HSE) secara luas juga memiliki dampak positif pada masyarakat, karena individu yang lebih sehat cenderung lebih produktif, memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit, dan berkontribusi pada pengurangan beban kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, program edukasi kesehatan sebaiknya lebih berfokus pada pengembangan *Health Self-Empowerment* (HSE) dalam masyarakat, sehingga individu dapat tumbuh menjadi lebih mandiri, berpengetahuan, dan berdaya dalam menjaga kesehatannya sendiri.

BAB 3

GAYA HIDUP SEHAT DI MASYARAKAT AGRIKULTURAL

A. Kondisi Kesehatan Masyarakat di Area Agrikultural

Masyarakat di area agrikultural menghadapi kondisi kesehatan yang beragam dan khas akibat keterkaitannya dengan sektor pertanian (Maisyaroh, 2017). . Lingkungan agrikultural sering kali membawa tantangan kesehatan yang kompleks, termasuk paparan pestisida, risiko cedera fisik dari penggunaan alat-alat pertanian, dan potensi infeksi dari lingkungan alam. Menurut penelitian, paparan pestisida pada petani Indonesia berisiko meningkatkan gangguan kesehatan, seperti penyakit pernapasan, kulit, hingga gangguan saraf akibat penggunaan bahan kimia tanpa kontrol yang ketat (Purnomo, 2019). Penggunaan pestisida sering kali masih dilakukan tanpa pemahaman penuh mengenai dampak jangka panjangnya, terutama jika tidak disertai penggunaan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Dampak akumulatif ini menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat agrikultural, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang keselamatan kerja.

Selain paparan bahan kimia, beban fisik yang berat dalam aktivitas sehari-hari di pertanian meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal, seperti

nyeri punggung, gangguan sendi, dan kelelahan kronis. Aktivitas seperti mencangkul, menanam, atau memanen seringkali memerlukan gerakan berulang yang menambah beban pada otot dan sendi, yang apabila berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan cedera (Sutrisno, 2020). Selain itu, paparan sinar matahari yang intens di area terbuka dapat menyebabkan masalah kulit dan kelelahan akibat dehidrasi, terutama saat musim tanam dan panen yang membutuhkan waktu lebih lama di ladang. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat di area agrikultural, baik dari segi fisik maupun lingkungan.

Namun, gaya hidup sehat di masyarakat agrikultural dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan penggunaan teknik pertanian yang lebih aman. Upaya untuk mengurangi risiko kesehatan telah dilakukan, misalnya melalui promosi praktik pertanian organik dan penggunaan APD, terutama saat menyemprot pestisida. Penggunaan APD, seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung, dapat membantu mengurangi paparan bahan kimia berbahaya yang terhirup atau bersentuhan langsung dengan kulit. Pemerintah dan organisasi lokal juga aktif memberikan pelatihan serta sosialisasi tentang penggunaan pestisida yang aman, dan pentingnya kebersihan diri setelah bekerja di lahan. Kementerian Pertanian (2022) misalnya, telah berupaya memberikan panduan tentang teknik pertanian yang aman untuk meminimalisir risiko bagi petani.

Program kesehatan yang difokuskan pada pemeriksaan kesehatan rutin untuk petani juga perlu diperluas guna mendeteksi dini masalah kesehatan yang berkaitan dengan aktivitas agrikultural. Deteksi dini dapat mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut, serta memastikan bahwa masyarakat agrikultural tetap sehat dan produktif. Dalam hal ini, kerja sama antara instansi kesehatan, petugas kesehatan desa, dan penyuluh pertanian menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat menjangkau area pedesaan dengan mudah. Selain kesehatan fisik, perhatian terhadap kesehatan mental di masyarakat agrikultural juga penting. Stres akibat ketidakpastian hasil panen, perubahan iklim, serta fluktuasi harga pasar dapat memengaruhi kesejahteraan mental petani (Hartono & Yulianto, 2022). Ketidakpastian ini membuat petani sering kali merasa cemas terhadap masa depan, yang dapat berpengaruh pada kondisi mental mereka.

Untuk itu, diperlukan dukungan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai di area pedesaan. Penyuluhan dan komunitas pendukung diharapkan dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan bagi para petani agar tetap termotivasi dan tidak merasa terisolasi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Gaya hidup sehat di lingkungan agrikultural dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah bekerja sama menjaga keseimbangan antara beban kerja dan praktik hidup sehat yang mendukung kualitas hidup masyarakat agrikultural. Pemahaman mengenai pentingnya kesehatan, baik fisik maupun

mental, serta penggunaan metode pertanian yang lebih aman, merupakan langkah penting untuk mewujudkan masyarakat agrikultural yang sehat dan produktif.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup Sehat di Wilayah Agrikultural

Wilayah agrikultural atau pedesaan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat, namun ada berbagai faktor yang turut memengaruhi penerapan gaya hidup sehat dalam masyarakat agrikultural. Beberapa faktor penting meliputi ketersediaan pangan, kebiasaan sosial dan budaya, kesadaran akan kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Para ahli berpendapat bahwa gaya hidup sehat di wilayah agrikultural ini sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dari faktor-faktor tersebut.

Pertama, ketersediaan pangan menjadi faktor penting dalam membentuk gaya hidup sehat di wilayah agrikultural. Masyarakat agrikultural biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan yang segar seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. Menurut peneliti gizi di Indonesia, Dr. Hardinsyah (2017), ketersediaan pangan lokal yang segar di pedesaan mampu mendukung asupan nutrisi yang lebih sehat karena cenderung lebih alami dan minim pengolahan dibandingkan dengan makanan olahan yang sering dikonsumsi di perkotaan. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat agrikultural dalam memenuhi kebutuhan gizi harian

yang lebih seimbang dan alami, sehingga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Namun demikian, faktor kebiasaan sosial dan budaya juga memainkan peran signifikan dalam gaya hidup sehat masyarakat agrikultural. Budaya gotong royong, misalnya, mendorong pola hidup aktif dan kebersamaan sosial, yang berkontribusi positif terhadap kesehatan mental dan fisik masyarakat. Kegiatan seperti bertani bersama, membersihkan lingkungan, atau acara-acara lokal yang mengedepankan aktivitas fisik, menjadi rutinitas yang menunjang kebugaran fisik masyarakat. Menurut Prof. Eko Suhartono (2016), seorang ahli sosiologi pedesaan di Universitas Gadjah Mada, keterlibatan dalam kegiatan sosial ini juga membantu menjaga kesehatan mental karena membangun solidaritas dan memberikan dukungan emosional yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat agrikultural sadar akan pentingnya gaya hidup sehat menjadi aspek yang memengaruhi penerapannya. Meski banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pola hidup sehat, kadang pengetahuan tentang kesehatan masih terbatas di wilayah agrikultural, terutama dalam hal pencegahan penyakit. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kebersihan, pola makan sehat, dan gaya hidup aktif. Sehingga masyarakat agrikultural yang mendapatkan edukasi rutin mengenai kesehatan cenderung menerapkan pola hidup sehat lebih baik, seperti mengonsumsi

makanan sehat, mengurangi konsumsi garam dan gula, serta menghindari rokok dan alkohol.

Akses terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi gaya hidup sehat di wilayah agrikultural. Walaupun banyak masyarakat agrikultural yang memiliki kebiasaan hidup aktif secara alami, akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil atau pedesaan masih terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat kadang sulit mendapatkan perawatan atau konsultasi medis yang memadai ketika mereka membutuhkan. Menurut Dr. Kartini Purnamasari (2018), seorang ahli kesehatan masyarakat, kesulitan akses ini kerap menghambat upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, karena perawatan kesehatan dan obat-obatan mungkin tidak tersedia secara cepat dan memadai. Meskipun masyarakat pedesaan memiliki keuntungan dalam hal pola hidup aktif dan lingkungan yang lebih alami, tantangan seperti keterbatasan akses kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang pencegahan penyakit, dan masalah lingkungan seperti penggunaan pestisida yang tidak terkontrol, tetap perlu diatasi.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, kondisi lingkungan di wilayah agrikultural juga berperan penting dalam mempengaruhi gaya hidup sehat masyarakat. Lingkungan yang lebih hijau, polusi udara yang lebih rendah, serta luasnya area untuk beraktivitas fisik memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat pedesaan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (2019), lingkungan pedesaan yang asri dan

alami cenderung menghasilkan kualitas udara yang lebih baik, serta menawarkan peluang lebih banyak untuk melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Aktivitas ini tidak hanya mendukung kesehatan kardiovaskular, tetapi juga berpotensi mengurangi risiko penyakit kronis. Meskipun demikian, tantangan lingkungan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki akses pelayanan kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

C. Perbedaan Gaya Hidup antara Masyarakat Agrikultural dan Perkotaan

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) (2024), perbedaan gaya hidup antara masyarakat agrikultural dan perkotaan terlihat jelas dalam beberapa aspek utama, seperti pola makan, aktivitas fisik untuk kesehatan mental, dan akses layanan kesehatan. Data tersebut ditampilkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1: Perbedaan Faktor Gaya Hidup Wilayah

Faktor	Wilayah Agrikultural	Wilayah Perkotaan
Ketersediaan Pangan Segar	75% konsumsi pangan lokal segar (sayuran, buah)	50% konsumsi pangan lokal segar
Aktivitas Fisik (Berjalan, Bersepeda)	60% terlibat aktivitas fisik sehari-hari	40% terlibat aktivitas fisik
Akses Kesehatan	45% kesulitan akses fasilitas kesehatan	25% kesulitan akses fasilitas kesehatan

Masyarakat agrikultural memiliki pola makan yang umumnya lebih sehat karena akses langsung ke bahan pangan segar, seperti sayur, buah, dan hasil pertanian lokal. Pola makan ini memberikan asupan gizi yang lebih baik dibandingkan masyarakat perkotaan, yang cenderung lebih sering mengonsumsi makanan olahan yang tinggi kalori, gula, dan garam. Konsumsi makanan olahan tersebut berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu, masyarakat agrikultural diuntungkan oleh aktivitas fisik yang lebih tinggi karena rutinitas kerja di bidang pertanian, seperti bercocok tanam dan memanen, yang memerlukan energi fisik besar. Mobilitas sehari-hari, seperti berjalan kaki atau bersepeda, juga menambah tingkat aktivitas mereka. Sebaliknya, masyarakat perkotaan lebih sering menjalani gaya hidup sedentari, seperti bekerja di depan komputer dalam waktu lama dan menggunakan kendaraan bermotor, sehingga lebih rentan terhadap obesitas dan penyakit jantung.

Pola aktivitas responden, 82 orang (33%) selalu melakukan aktivitas dengan menggunakan tenaga saat bekerja dan 55 orang (22%) selalu mengalami nyeri saat bekerja. Pada gambar 1 dan 2 didapatkan, untuk menuju tempat kerja mayoritas responden berjalan kaki yaitu sebanyak 112 orang (45%) dengan waktu perjalanan menuju kerja rata-rata <15 menit (Astuti et al., 2024). Pola makan merupakan suatu susunan dan jumlah makanan terdiri dari frekuensi makan, jenis makanan, dan porsi makan yang dikonsumsi oleh seseorang atau kelompok pada waktu tertentu. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 192 responden (77%) memiliki frekuensi makan 3x dalam sehari, 137 responden (55%) selalu sarapan sebelum berangkat kerja, 77 responden (31%) belum menerapkan porsi makan sesuai ISI PIRINGKU, 96 responden (38%) rutin mengonsumsi sayur tiap makan, 107 responden (43%) belum rutin makan buah tiap hari. Namun dalam penelitian sebanyak 96 responden (39%) merasa bahwa asupan nutrisinya sudah mencukupi kebutuhan energi dan tidak menyadari bahwa Ketidak teraturan pola makan misalnya telat makan, makan terlalu banyak atau sedikit, makan terburu-buru, makan makanan yang terlalu banyak bumbu, mengonsumsi makanan pedas, konsumsi protein tinggi, kebiasaan meminum kopi terlalu berlebihan dapat menyebabkan tubuh rentan mengalami sakit.

Namun, tantangan utama bagi masyarakat agrikultural terletak pada akses terhadap layanan kesehatan. Wilayah agrikultural sering kali memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas baik dalam jumlah

maupun kualitas, seperti kurangnya tenaga medis dan jarak jauh ke pusat kesehatan. Ini dapat memperlambat deteksi dini penyakit dan pengobatan. Masyarakat perkotaan, meskipun memiliki akses lebih mudah ke layanan medis, sering menghadapi kendala lain seperti antrean panjang, biaya tinggi, dan keterbatasan waktu akibat kesibukan kerja.

Kualitas lingkungan juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat agrikultural. Wilayah agrikultural biasanya memiliki polusi udara yang lebih rendah dan lebih banyak ruang hijau, yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Sebaliknya, masyarakat perkotaan sering terpapar polusi udara tinggi akibat emisi kendaraan dan aktivitas industri, yang berdampak buruk pada kesehatan pernapasan. Meskipun demikian, masyarakat agrikultural masih memerlukan peningkatan dalam hal akses layanan kesehatan untuk mendukung keberlanjutan gaya hidup sehat, sedangkan masyarakat perkotaan perlu mengatasi dampak gaya hidup sedentari dan tantangan lingkungan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

BAB 4

PENERAPAN MODEL *HEALTH SELF-EMPOWERMENT* DALAM MODIFIKASI GAYA HIDUP SEHAT

A. **Komponen Utama Model *Health Self-Empowerment***

Masyarakat agrikultural memiliki karakteristik unik yang memengaruhi pola hidup sehat mereka, seperti aktivitas fisik yang tinggi, konsumsi makanan tradisional, dan akses terbatas ke layanan kesehatan modern. Model Teori Betty Neuman (1982), menekankan pentingnya mempertahankan stabilitas sistem klien melalui pencegahan gangguan kesehatan pada tingkat primer, sekunder, dan tersier. Pada *Health Self-Empowerment* (HSE) teori ini bertujuan menilai lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kesehatan suatu masyarakat, serta melakukan diagnosis dan intervensi berdasarkan tingkat ancaman yang ditimbulkan. Beberapa komponen utama yang dapat diadaptasi dalam konteks masyarakat agrikultural guna mengatasi tantangan spesifik, frekuensi penyakit, serta terbatasnya dukungan infrastruktur kesehatan.

1. Pengetahuan Kesehatan (*Health Knowledge*)

Dalam masyarakat agrikultural, edukasi tentang penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan dampak pola makan yang tidak seimbang sangat penting. Contohnya, penyuluhan

kesehatan yang menghubungkan antara konsumsi karbohidrat tinggi dengan obesitas dan diabetes telah terbukti meningkatkan kesadaran warga. Pengetahuan kesehatan berakar pada konsep *Health Belief Model* (HBM) yang dikembangkan oleh Rosenstock (1974). Model ini menyatakan bahwa pengetahuan tentang risiko kesehatan dan manfaat perubahan perilaku dapat mendorong individu untuk bertindak.

Edukasi tentang pola makan seimbang dan pencegahan penyakit seperti diabetes serta hipertensi sangat penting, karena masyarakat agrikultural sering terjebak dalam pola makan berbasis hasil pertanian yang kurang bervariasi. Selain itu, keterbatasan akses informasi sering kali membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya pencegahan.

2. Keyakinan Diri (*Self-Efficacy*)

Keyakinan diri atau *self-efficacy* adalah kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan dan mempertahankan perubahan gaya hidup sehat. Konsep ini diperkenalkan oleh Albert Bandura (1977) dalam *Social Cognitive Theory*. Bandura menyatakan bahwa *self-efficacy* adalah prediktor utama dari keberhasilan perubahan perilaku. Pengalaman sukses sebelumnya, pengamatan terhadap orang lain, dan dukungan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan *self-efficacy*.

Dalam konteks agrikultural, *self-efficacy* dapat dibangun melalui kegiatan berbasis

komunitas, seperti demonstrasi praktik bertani sehat atau pembelajaran bersama tokoh lokal. Jika individu melihat keberhasilan orang lain di komunitas mereka, mereka lebih percaya diri untuk memulai perubahan serupa, misalnya menanam sayuran organik untuk konsumsi keluarga.

3. Pengendalian Diri (*Self-Control*)

Konsistensi dalam menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi makanan tinggi lemak membutuhkan pengendalian diri yang kuat. Teknik sederhana seperti mencatat kebiasaan makan harian dan menetapkan tujuan realistis dapat membantu individu tetap berada di jalur sehat. *Self-control* terkait erat dengan teori kontrol diri yang dikembangkan oleh Michael Baumeister (2004).

Dalam konteks kesehatan, kemampuan untuk menahan diri dari kebiasaan buruk seperti mengonsumsi makanan tidak sehat menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang perubahan gaya hidup. Petani sering kali menghadapi rutinitas fisik yang melelahkan, sehingga sulit untuk mempertahankan konsistensi perilaku sehat. Dengan pengaturan tujuan harian dan refleksi terhadap pencapaian, individu dapat meningkatkan pengendalian diri mereka.

4. Motivasi (*Motivation*)

Motivasi dipicu oleh tujuan yang relevan, seperti peningkatan produktivitas kerja atau kesehatan keluarga. Dalam masyarakat

agrikultural, penghargaan komunitas atau pengakuan sosial menjadi alat efektif untuk meningkatkan motivasi individu dalam memodifikasi gaya hidup. *Self-Determination Theory* (SDT) yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan (1985) menjelaskan jika motivasi intrinsik (keinginan untuk kesehatan pribadi) dan ekstrinsik (pengakuan atau penghargaan) memengaruhi perilaku individu.

Motivasi intrinsik cenderung memberikan efek jangka panjang karena didasari oleh kebutuhan pribadi. Motivasi dapat ditingkatkan dengan mengaitkan manfaat kesehatan dengan tujuan yang relevan secara lokal, seperti peningkatan produktivitas kerja. Misalnya, penyuluhan kesehatan yang menunjukkan hubungan antara kesehatan jantung dengan kemampuan bekerja optimal dapat menarik perhatian masyarakat agrikultural.

5. Dukungan Sosial (*Social Support*)

Dukungan keluarga dan komunitas memiliki peran kunci dalam keberhasilan perubahan kebiasaan. Misalnya, kelompok tani sehat atau forum diskusi lokal dapat memberikan semangat bersama untuk menjalankan gaya hidup sehat. House (1988) dalam studi tentang *social support* menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga membantu individu dalam menghadapi tekanan psikologis.

Komponen ini penting dalam kelompok dengan keterikatan komunitas yang tinggi,

seperti masyarakat agrikultural. Pembentukan kelompok tani sehat, pertemuan komunitas, atau kegiatan olahraga bersama dapat memperkuat dukungan sosial. Dalam situasi ini, individu merasa lebih termotivasi untuk tetap konsisten menjalani kebiasaan sehat karena mereka tidak merasa sendiri.

6. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to Resources*)

Komponen ini melibatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, informasi, dan sarana olahraga menjadi tantangan besar di daerah agrikultural. Inovasi seperti *telemedicine* dan pelibatan pemerintah dalam penyediaan bahan pangan sehat menjadi solusi untuk meningkatkan akses ini.

Teori ekologi sosial dari Bronfenbrenner (1979) menyoroti pentingnya lingkungan fisik dan sosial dalam mendukung perilaku sehat. Akses terhadap sumber daya yang memadai menjadi faktor penentu utama dalam perubahan perilaku. Masyarakat agrikultural sering kali tinggal di daerah terpencil, di mana fasilitas kesehatan terbatas. Penyediaan sumber daya seperti pos kesehatan desa, fasilitas olahraga sederhana, atau program subsidi makanan sehat dapat membantu mengatasi hambatan ini.

B. Strategi Penerapan *Health Self-Empowerment* untuk Masyarakat Agrikultural

Suatu kegiatan dapat dikategorikan pemberdayaan bila mampu memperkuat,

meningkatkan, atau mengembangkan potensi masyarakat setempat (Pranata, Pratiwi, & Rahanto, 2011). Strategi penerapan *Health Self-Empowerment* untuk masyarakat agrikultural harus mencakup pembekalan pengetahuan kesehatan, pemberdayaan untuk memperkuat keyakinan diri dan pengendalian diri, motivasi untuk menjaga kesehatan, serta penguatan dukungan sosial dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan, sebagai berikut.

1. Pengetahuan Kesehatan (*Health Knowledge*)

Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat agrikultural, langkah strategis pertama adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan edukasi kesehatan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Nutbeam (2010). Program pelatihan dapat mencakup topik seperti pentingnya gizi seimbang, cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta pencegahan penyakit yang umum terjadi di lingkungan agrikultural, seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu atau bahan kimia, dehidrasi karena bekerja di bawah sinar matahari, dan cedera fisik akibat pekerjaan berat. Menurut Green dan Kreuter (2005), seminar atau lokakarya ini bisa dilaksanakan secara rutin di desa atau tempat komunitas berkumpul, dengan menghadirkan narasumber ahli yang dapat memberikan penjelasan secara langsung. Format kegiatan yang interaktif dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat dapat membantu

menyampaikan pesan dengan lebih efektif, misalnya melalui simulasi atau permainan edukatif.

Selain itu, penggunaan media yang tepat menjadi bagian penting untuk menyebarkan informasi kesehatan. Media sosial, aplikasi ponsel, dan siaran radio lokal dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat dengan informasi yang praktis dan mudah dimengerti (Lambert & Loiselle, 2007). Radio, khususnya, masih menjadi alat komunikasi yang efektif di wilayah pedesaan karena aksesibilitasnya yang luas. Melalui siaran khusus tentang kesehatan, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang cara pencegahan penyakit, tips kebersihan, atau resep makanan sehat yang sesuai dengan bahan pangan yang tersedia di lingkungan mereka. Bagi masyarakat yang menggunakan ponsel, aplikasi sederhana berbasis kesehatan dapat dirancang untuk memberikan pengingat harian, seperti waktu minum air, jadwal istirahat, atau langkah-langkah pertolongan pertama.

Untuk memastikan informasi yang disampaikan berbasis bukti dan relevan, kolaborasi dengan tenaga kesehatan sangat diperlukan. Dokter, bidan, dan ahli gizi dapat dilibatkan dalam kegiatan edukasi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kesehatan. Kolaborasi ini juga dapat diwujudkan melalui program kunjungan berkala tenaga kesehatan ke desa-desa, di mana mereka tidak hanya memberikan materi edukasi tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan

sederhana seperti pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan status gizi. Pendekatan langsung ini memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih dekat dengan layanan kesehatan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap informasi yang diberikan. Dengan cara ini, upaya kesehatan yang diberikan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga menciptakan kebiasaan yang lebih baik untuk keberlangsungan hidup mereka di masa depan.

2. Keyakinan Diri (*Self-Efficacy*)

Meningkatkan keyakinan diri (*self-efficacy*) merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat agrikultural untuk mengelola kesehatan mereka secara mandiri (Schwarzer, 1992). Salah satu strategi efektif adalah melalui fasilitasi keberhasilan kecil yang mudah dicapai. Misalnya, masyarakat dapat didorong untuk mengadopsi perubahan sederhana seperti mengatur pola makan sehat, yang relevan dengan hasil panen lokal, atau menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan membiasakan cuci tangan setelah memegang alat-alat pertanian. Dengan pencapaian kecil ini, masyarakat akan merasa lebih percaya diri dalam kemampuannya untuk membuat perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Setiap langkah kecil yang berhasil dicapai memberikan dorongan mental positif dan menanamkan keyakinan bahwa mereka memiliki kendali atas kondisi kesehatannya.

Selain itu, modeling menjadi pendekatan yang sangat ampuh untuk membangun *self-*

efficacy. Menampilkan kisah sukses dari anggota komunitas yang telah berhasil menerapkan gaya hidup sehat dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat lain. Misalnya, seorang petani yang berhasil menurunkan risiko penyakit dengan menerapkan pola makan seimbang dan rutin melakukan aktivitas fisik ringan dapat diundang untuk berbagi pengalamannya. Kisah-kisah seperti ini tidak hanya memberikan contoh nyata tentang langkah yang dapat diambil tetapi juga membangun keyakinan bahwa kesuksesan serupa dapat dicapai oleh siapa saja. Dalam konteks ini, penting juga untuk memastikan bahwa cerita-cerita yang dibagikan relevan dengan kondisi, tantangan, dan kebutuhan unik masyarakat agrikultural, sehingga lebih mudah diadaptasi oleh individu lain.

Pemberian penghargaan atas pencapaian kesehatan tertentu juga merupakan komponen penting. Penghargaan ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti sertifikat, pengakuan publik, atau bahkan insentif material seperti alat kesehatan dasar. Contohnya, penghargaan dapat diberikan kepada kelompok tani yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan kerja selama periode tertentu atau kepada individu yang konsisten mempraktikkan gaya hidup sehat. Dengan adanya penghargaan ini, masyarakat tidak hanya merasa dihargai atas usahanya tetapi juga termotivasi untuk terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan perilaku sehat. Penghargaan semacam ini juga dapat

memperkuat solidaritas dan dukungan sosial di antara anggota komunitas, menciptakan atmosfer yang kondusif untuk perubahan positif.

Melalui kombinasi keberhasilan kecil, model percontohan yang inspiratif, dan penghargaan, masyarakat agrikultural akan memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan mereka. Peningkatan *self-efficacy* ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga dapat menular ke seluruh komunitas, menciptakan budaya kesehatan yang lebih baik (Gutiérrez, 1995). Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera, baik secara fisik maupun mental. Strategi ini tidak hanya memberdayakan tetapi juga memastikan keberlanjutan upaya peningkatan kesehatan masyarakat agrikultural.

3. Pengendalian Diri (*Self-Control*)

Dalam konteks ini, pengendalian diri dapat dimulai dengan memperkenalkan teknik manajemen stres yang efektif. Stres seringkali menjadi masalah utama bagi para petani karena beban kerja yang berat, seperti tekanan dalam mencapai hasil panen, cuaca yang tidak menentu, atau kebutuhan untuk memenuhi target ekonomi keluarga. Teknik sederhana seperti meditasi dapat diajarkan untuk membantu masyarakat menenangkan pikiran (Lazarus & Folkman, 1984). Meditasi memberikan ruang untuk refleksi dan relaksasi, yang dapat membantu mengurangi ketegangan mental. Selain itu, latihan pernapasan

dalam juga sangat bermanfaat karena dapat memberikan efek menenangkan secara instan, terutama saat menghadapi situasi yang penuh tekanan. Latihan fisik ringan, seperti senam pagi atau berjalan kaki di sekitar area pertanian, juga dapat membantu mengurangi stres sekaligus meningkatkan kesehatan fisik.

Selain manajemen stres, pengendalian diri juga dapat didukung melalui program pengaturan waktu yang dirancang untuk masyarakat agrikultural. Banyak petani sering kali menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja di ladang tanpa menyadari pentingnya jeda istirahat. Program ini bertujuan membantu mereka mengelola waktu secara lebih seimbang antara pekerjaan dan perawatan diri. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan panduan sederhana mengenai pentingnya istirahat yang cukup, termasuk manfaat tidur yang berkualitas. Istirahat yang cukup tidak hanya memperbaiki kesehatan fisik tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kerja.

Dalam program ini, petani juga dapat diajak untuk membuat jadwal kerja harian yang realistis, dengan alokasi waktu untuk kegiatan yang mendukung kesehatan seperti berolahraga, makan dengan teratur, atau sekadar meluangkan waktu bersama keluarga. Sebagai bagian dari pendekatan ini, pelatihan manajemen waktu juga dapat mencakup penggunaan alat bantu sederhana seperti pengingat waktu pada ponsel atau kalender kerja mingguan yang disesuaikan

dengan musim tanam dan panen. Dengan demikian, petani dapat lebih mudah memprioritaskan tugas tanpa mengorbankan waktu istirahat. Di sisi lain, pengelolaan waktu yang baik juga dapat mencegah kelelahan kronis yang sering dialami masyarakat agrikultural, yang jika dibiarkan dapat menurunkan kualitas hidup mereka (Penedo & Dahn, 2005). Kemampuan untuk mengelola stres dan waktu ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga memberikan dampak positif bagi produktivitas komunitas.

4. Motivasi (*Motivation*)

Motivasi merupakan elemen penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat agrikultural menuju gaya hidup yang lebih sehat (Ryan & Deci, 2000). Salah satu strategi efektif adalah melalui pemberian insentif. Insentif dapat berupa penghargaan seperti *voucher*, bantuan kesehatan, atau fasilitas pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat agrikultural. Misalnya, kelompok tani yang aktif mengikuti program kesehatan dapat diberikan paket suplemen, alat pelindung diri, atau akses gratis ke layanan medis dasar. Insentif ini tidak hanya menjadi penghargaan atas partisipasi mereka, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa upaya menjaga kesehatan dihargai dan memiliki dampak nyata pada kualitas hidup mereka. Selain itu, pemberian insentif mampu memotivasi masyarakat untuk terus terlibat dalam

program kesehatan dan menjadi *role model* bagi orang lain di masyarakat.

Selain insentif individual, motivasi sosial juga memainkan peran besar dalam memperkuat komitmen masyarakat agrikultural terhadap kesehatan. Mengadakan kompetisi atau tantangan kelompok, seperti "Tantangan Sehat Antar Kelompok Tani," dapat menjadi cara yang menyenangkan sekaligus efektif untuk meningkatkan motivasi. Tantangan ini dapat mencakup aktivitas seperti siapa yang berhasil menanam tanaman organik paling banyak, menjaga pola makan sehat dalam jangka waktu tertentu, atau meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan rumah. Aktivitas-aktivitas tersebut, selain bersifat kompetitif, memberikan ruang untuk belajar bersama, saling mendukung, dan menciptakan rasa kebersamaan di dalam komunitas. Pemenang kompetisi dapat diberikan penghargaan, seperti alat pertanian modern, akses khusus ke pasar hasil panen, atau pelatihan eksklusif yang meningkatkan keterampilan mereka. Dengan begitu, tidak hanya motivasi kesehatan yang ditingkatkan, tetapi juga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat agrikultural secara keseluruhan.

Strategi berbasis motivasi ini bekerja karena masyarakat agrikultural umumnya memiliki ikatan komunitas yang kuat. Kompetisi kelompok memanfaatkan nilai-nilai kolektivitas ini, sehingga perubahan perilaku sehat tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga

menjadi bagian dari kesuksesan bersama. Motivasi sosial juga menumbuhkan kebanggaan terhadap pencapaian komunitas, yang pada akhirnya dapat memperkuat keinginan mereka untuk terus menjalani kebiasaan hidup sehat. Insentif memberikan daya tarik awal untuk mengikuti program, sementara motivasi sosial menjaga keberlanjutan partisipasi mereka dalam jangka panjang. Strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menciptakan perubahan budaya yang signifikan dalam cara masyarakat agrikultural memandang kesehatan.

5. Dukungan Sosial (*Social Support*)

Dukungan Sosial (*Social Support*) memegang peran penting dalam membangun kesadaran dan kebiasaan kesehatan yang berkelanjutan di masyarakat agrikultural. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan di tingkat komunitas. Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi anggota masyarakat agar dapat berbagi informasi terkait kesehatan, saling mendukung secara moral, dan bertukar pengalaman mengenai cara mengelola kesehatan secara efektif di lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Dalam kelompok ini, para anggota dapat mendiskusikan berbagai tantangan kesehatan yang mereka hadapi, seperti pencegahan cedera akibat pekerjaan lapangan, menjaga kebersihan lingkungan, atau pola makan sehat di tengah kesibukan bertani. Selain itu, kelompok ini juga dapat menjadi wadah untuk menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan kolaboratif, seperti senam bersama, lokakarya kesehatan, atau kampanye hidup sehat yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Melalui dukungan antaranggota, rasa tanggung jawab kolektif terhadap kesehatan masyarakat dapat terbentuk, sehingga perilaku sehat menjadi bagian dari norma sosial yang dihargai di komunitas tersebut.

Melibatkan pemimpin masyarakat dalam upaya penerapan kesehatan dapat menjadi kunci keberhasilan karena nasihat dan contoh yang diberikan lebih mudah diterima dan dipandang relevan oleh masyarakat. Pemimpin lokal dapat berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, memberikan motivasi, serta memastikan keberlanjutan inisiatif yang telah dilaksanakan. Misalnya, seorang kepala desa dapat memimpin kampanye kebersihan lingkungan atau mengajak warga mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin. Pendampingan ini tidak hanya memberikan dorongan emosional kepada masyarakat tetapi juga memperlihatkan komitmen bersama dalam menciptakan kehidupan yang lebih sehat. Selain itu, keterlibatan pemimpin lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan yang diinisiasi, sehingga mereka lebih bersemangat untuk berpartisipasi aktif.

Pendekatan berbasis dukungan sosial ini memiliki keunggulan dalam membangun solidaritas dan kerja sama antarwarga, yang pada

akhirnya dapat memperkuat kemampuan masyarakat agrikultural untuk menghadapi tantangan kesehatan secara kolektif (Ministry of Health Indonesia, 2020). Dengan adanya kelompok dukungan sehat yang solid serta peran aktif dari pemimpin lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dan dukungan moral tetapi juga merasa didampingi dalam proses perubahan menuju gaya hidup yang lebih sehat. Dukungan sosial yang kuat juga dapat mengurangi rasa isolasi yang mungkin dirasakan oleh individu yang menghadapi masalah kesehatan tertentu, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah positif dalam menjaga kesejahteraan diri. Kombinasi dari pendekatan ini diharapkan mampu mendorong penerapan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan di kalangan masyarakat agrikultural.

6. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to Resources*)

Untuk mendukung kesehatan masyarakat agrikultural, diperlukan strategi yang tepat dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, distribusi sumber daya kesehatan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat tersebut memiliki sarana yang cukup untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya.

Langkah pertama adalah meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Masyarakat

agrikultural sering kali tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan, seperti puskesmas atau klinik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya untuk menyediakan layanan kesehatan rutin di dekat lokasi mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program kunjungan kesehatan keliling atau pos kesehatan desa yang berfungsi sebagai titik layanan sementara. Di pos-pos ini, masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, mendapatkan imunisasi, dan menerima penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan dini. Deteksi dini penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau masalah kesehatan lainnya sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Selain itu, pelibatan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, atau dokter umum dalam program ini akan memastikan masyarakat menerima layanan kesehatan yang berkualitas. Penyuluhan ini bisa mencakup informasi tentang pola hidup sehat, pengelolaan stres, pentingnya kebersihan, hingga cara mencegah penyakit menular yang sering terjadi di daerah pedesaan.

Langkah berikutnya adalah distribusi sumber daya kesehatan. Agar masyarakat dapat menjaga kesehatannya, mereka membutuhkan akses yang memadai terhadap alat-alat kesehatan dasar seperti masker, antiseptik, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya. Hal ini sangat relevan, terutama ketika mereka bekerja di lapangan yang penuh risiko terpapar debu, bahan

kimia, atau faktor lingkungan lain yang berpotensi mengganggu kesehatan. Selain alat pelindung diri, distribusi bahan pangan bergizi juga perlu menjadi prioritas. Meskipun masyarakat agrikultural sering kali terlibat dalam produksi pangan, akses mereka terhadap makanan bernutrisi seimbang sering terbatas karena keterbatasan ekonomi atau pengetahuan tentang gizi.

Program distribusi ini juga harus mencakup suplemen dan obat-obatan penting, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Kerjasama dengan lembaga kesehatan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat memperlancar distribusi ini. Contohnya, melalui program bantuan pangan bergizi atau subsidi untuk obat-obatan tertentu, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan kebutuhan dasar kesehatan. Distribusi ini harus dilakukan secara merata dan adil, dengan mempertimbangkan wilayah yang paling membutuhkan. Salah satu hambatan terbesar yang sering dialami masyarakat agrikultural adalah jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan atau perbaikan jalan menuju klinik atau puskesmas menjadi langkah strategis. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah akses ke layanan kesehatan tetapi juga mengurangi waktu tempuh yang sering kali menjadi alasan masyarakat enggan memeriksakan diri.

Selain perbaikan fisik, inovasi digital seperti layanan telemedisin juga dapat menjadi solusi

untuk mengatasi keterbatasan jarak. Dengan *telemedicine*, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan tanpa harus bepergian jauh. Ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Namun, untuk mewujudkan layanan *telemedicine*, diperlukan akses internet yang memadai (Purnomo, 2019). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas jaringan internet ke desa-desa agrikultural agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti ambulans desa atau kendaraan darurat juga penting untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera dapat dengan cepat dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan kendaraan ini tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penting juga untuk memastikan keberlanjutan program-program ini dengan melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Partisipasi aktif masyarakat, misalnya melalui kelompok tani atau lembaga masyarakat desa, akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan. Selain itu, pelibatan ini akan memastikan bahwa program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan meningkatkan

akses ke layanan kesehatan melalui program kunjungan keliling dan penyuluhan, mendistribusikan sumber daya kesehatan secara adil, serta memperbaiki infrastruktur kesehatan, masyarakat agrikultural akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka tetapi memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

C. Manfaat *Health Self-Empowerment*, (HSE) dalam Pengelolaan Kesehatan Pribadi dan Komunitas

Kesehatan merupakan aset yang sangat berharga bagi individu dan komunitas, terutama bagi masyarakat agrikultural yang kehidupannya sangat tergantung pada keberlangsungan fisik dan mental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, *Health Self-Empowerment* (HSE) atau pemberdayaan diri dalam kesehatan menjadi konsep yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. *Health Self-Empowerment* (HSE) merujuk pada kemampuan individu atau komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan, mengakses informasi, mengambil keputusan berbasis pengetahuan, dan secara aktif melakukan tindakan preventif atau pengobatan untuk meningkatkan kesehatan. Implementasi *Health Self-Empowerment* (HSE) dalam komunitas agrikultural memiliki manfaat besar, baik dalam skala pribadi maupun masyarakat.

1. Manfaat *Health Self-Empowerment* (HSE) pada Pengelolaan Kesehatan Pribadi

Pada tingkat individu *Health Self-Empowerment* (HSE) memungkinkan seseorang untuk lebih memahami tubuhnya sendiri dan kebutuhan kesehatannya. Dalam masyarakat agrikultural, individu sering kali menghadapi risiko kesehatan yang terkait dengan pekerjaan fisik berat, paparan bahan kimia seperti pestisida, serta kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan mengadopsi *Health Self-Empowerment* (HSE) petani atau pekerja agrikultural dapat belajar mengenali gejala awal penyakit, memahami pentingnya pola makan seimbang, dan mempraktikkan langkah pencegahan seperti penggunaan alat pelindung diri saat bekerja.

Salah satu contoh nyata adalah bagaimana *Health Self-Empowerment* (HSE) mendorong individu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Melalui edukasi kesehatan yang terarah, individu memahami pentingnya memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan fungsi organ tubuh. Dengan informasi ini, mereka dapat mencegah komplikasi yang lebih serius, seperti hipertensi atau diabetes, yang sering terjadi di komunitas dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Selain itu, *Health Self-Empowerment* (HSE) membantu individu dalam mengelola stres. Pekerjaan agrikultural sering kali penuh tekanan karena ketergantungan pada faktor eksternal seperti cuaca dan pasar.

2. Manfaat *Health Self-Empowerment* (HSE) bagi Komunitas Agrikultural

Pada komunitas agrikultral, *Health Self-Empowerment* (HSE) memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan kolektif. Komunitas agrikultural biasanya memiliki struktur sosial yang kuat, sehingga edukasi kesehatan berbasis komunitas dapat diterapkan dengan efektif. Dengan memberdayakan anggota komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, *Health Self-Empowerment* (HSE) menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara bersama-sama.

Sebagai contoh, komunitas yang memahami pentingnya sanitasi dapat bekerja sama untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah dan menyediakan akses air bersih. Ini mengurangi risiko penyakit menular seperti diare atau infeksi kulit yang sering terjadi di daerah pedesaan. Selain itu, *Health Self-Empowerment* (HSE) juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan pengelolaan tanah yang sehat, yang secara tidak langsung mendukung kesehatan mereka. *Health Self-Empowerment* (HSE) juga mendorong pembentukan kelompok dukungan kesehatan di dalam komunitas. Kelompok ini bisa berfungsi sebagai wadah untuk saling berbagi informasi, memberikan dukungan emosional, atau mengorganisir kegiatan seperti olahraga bersama, pemeriksaan kesehatan massal, dan seminar tentang kesehatan. *Health Self-Empowerment*

(HSE) di masyarakat agrikultural membutuhkan pendekatan yang kontekstual. Salah satu cara efektif adalah melalui pendidikan berbasis komunitas. Penyuluhan kesehatan dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, seperti kepala desa atau pemimpin kelompok tani. Penyampaian informasi dalam bahasa lokal dan dengan metode yang mudah dipahami, seperti permainan atau visualisasi, dapat meningkatkan efektivitas pesan.



Gambar 4.1: Posisi Kerja

Selain itu, pengembangan teknologi informasi juga penting dalam mendukung *Health Self-Empowerment* (HSE). Akses ke platform digital yang menyediakan informasi kesehatan dapat membantu individu dan komunitas mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, aplikasi seluler yang memberikan panduan tentang pola makan sehat, teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan, atau cara mengelola

penyakit tertentu dapat diakses oleh masyarakat agrikultural, terutama mereka yang memiliki ponsel. Pelatihan keterampilan kesehatan bagi komunitas juga menjadi bagian penting dari *Health Self-Empowerment* (HSE). Program seperti pelatihan pertolongan pertama atau penggunaan obat-obatan tradisional yang aman dapat meningkatkan kemandirian komunitas dalam mengatasi masalah kesehatan yang sering muncul. Hal ini sangat bermanfaat di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan. Sehingga *Health Self-Empowerment* (HSE) merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan komunitas agrikultural. Dengan pemberdayaan diri dalam kesehatan, individu dapat lebih mandiri dalam mengelola kesehatannya, sementara komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif (Suryani & Hadi, 2020). Meskipun tantangan dalam implementasi *Health Self-Empowerment* (HSE) masih ada, langkah-langkah strategis seperti pendidikan berbasis komunitas, penggunaan teknologi, dan pelatihan keterampilan kesehatan dapat mengatasi hambatan tersebut.

BAB 5

HEALTH SELF-EMPOWERMENT DAN PENGELOLAAN *BODY MASS INDEX* (BMI)

A. Peran *Body Mass Index* (BMI) sebagai Indikator Kesehatan

Body Mass Index (BMI) atau Indeks Massa Tubuh merupakan salah satu indikator sederhana yang digunakan untuk menilai status gizi individu berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Metode ini telah menjadi alat yang umum digunakan dalam berbagai studi kesehatan masyarakat, termasuk pada komunitas agrikultural. Menurut World Health Organization (2004), *Body Mass Index* (BMI) dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m^2). Hasil penghitungan ini kemudian dikategorikan ke dalam beberapa rentang, seperti kurang gizi ($\text{BMI} < 18,5$), normal ($18,5\text{--}24,9$), kelebihan berat badan ($25\text{--}29,9$), dan obesitas (≥ 30).

Masyarakat agrikultural biasanya menjalani gaya hidup yang berbeda dari masyarakat perkotaan, dengan aktivitas fisik yang tinggi dan pola makan yang khas. Pekerjaan di sektor agrikultural sering kali melibatkan aktivitas fisik yang berat seperti mencangkul, menanam, dan memanen, yang secara langsung memengaruhi kebutuhan energi tubuh. Namun, meskipun aktivitas fisik tinggi dapat

membantu menjaga berat badan, kurangnya akses terhadap makanan bergizi sering kali menjadi tantangan (Khomsan, 2004). Dalam hal ini, *Body Mass Index* (BMI) menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi masalah kesehatan gizi pada masyarakat agrikultural. Misalnya, *Body Mass Index* (BMI) rendah dapat mengindikasikan risiko malnutrisi atau kekurangan energi kronis, yang sering terjadi di komunitas dengan akses terbatas terhadap protein, vitamin, dan mineral. Namun, *Body Mass Index* (BMI) tidak hanya berfungsi untuk mengukur kekurangan gizi. Di beberapa daerah agrikultural, terutama yang mulai mengalami modernisasi, risiko kelebihan berat badan dan obesitas juga meningkat. Faktor seperti perubahan pola makan akibat meningkatnya akses terhadap makanan olahan dan berkalori tinggi, serta pengurangan aktivitas fisik karena mekanisasi pertanian, berkontribusi terhadap masalah ini (Astuti, 2016). Oleh karena itu, *Body Mass Index* (BMI) juga dapat digunakan untuk memantau tren epidemiologi kelebihan berat badan dan obesitas, yang sering kali dikaitkan dengan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit *kardiovaskular*.

Meskipun *Body Mass Index* (BMI) memiliki keunggulan sebagai alat yang sederhana dan mudah digunakan, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Menurut National Institute of Health (1998), *Body Mass Index* (BMI) tidak membedakan antara massa otot dan lemak tubuh. Hal ini penting, terutama di kalangan pekerja agrikultural yang memiliki massa otot tinggi karena

pekerjaan fisik mereka. Dalam situasi ini, seseorang dengan *Body Mass Index* (BMI) yang masuk kategori kelebihan berat badan mungkin sebenarnya memiliki proporsi lemak tubuh yang normal tetapi massa otot yang tinggi. Oleh karena itu, interpretasi hasil *Body Mass Index* (BMI) dalam komunitas agrikultural harus mempertimbangkan konteks pekerjaan fisik dan komposisi tubuh.

Menurut Hardinsyah (2009) *Body Mass Index* (BMI) tidak memberikan informasi mengenai distribusi lemak tubuh, yang merupakan faktor penting dalam menentukan risiko kesehatan. Misalnya, akumulasi lemak di area *abdominal* (lemak *visera*) memiliki hubungan yang lebih kuat dengan risiko penyakit metabolik dibandingkan dengan lemak *subkutan* di bagian tubuh lainnya. Dalam hal ini, pengukuran tambahan seperti lingkaran pinggang atau rasio lingkaran pinggang-pinggul dapat melengkapi *Body Mass Index* (BMI) untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang status kesehatan masyarakat agrikultural.

Sebagai indikator kesehatan masyarakat, *Body Mass Index* (BMI) juga dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program intervensi gizi (Sukandar, Khomsan, & Riyadi, 2009). Pemerintah dan organisasi kesehatan dapat menggunakan data *Body Mass Index* (BMI) untuk mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi terhadap kekurangan gizi atau obesitas. Informasi ini sangat berguna untuk merancang program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, atau promosi aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat agrikultural.

Misalnya, di daerah dengan prevalensi *Body Mass Index* (BMI) rendah, penilaian dapat difokuskan pada peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan edukasi mengenai pentingnya pola makan seimbang. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat obesitas tinggi, kampanye promosi gaya hidup sehat dan peningkatan kesadaran tentang dampak konsumsi makanan olahan mungkin lebih relevan (Suryowati & Rochmah, 2015).

Dalam jangka panjang, penggunaan *Body Mass Index* (BMI) sebagai indikator kesehatan masyarakat agrikultural juga dapat membantu memantau perubahan pola gizi dan kesehatan yang terjadi seiring dengan transformasi sosial-ekonomi. Dengan meningkatnya mekanisasi dan modernisasi, pola makan masyarakat agrikultural cenderung bergeser dari makanan tradisional berbasis nabati ke makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Perubahan ini sering kali disertai dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular. Menurut penelitian yang dilakukan Prihatini dan Febry (2017), dengan memonitor tren *Body Mass Index* (BMI) secara berkala, para pembuat kebijakan dapat mengantisipasi dan merancang strategi mitigasi yang tepat. Namun, penting untuk diingat bahwa *Body Mass Index* (BMI) hanyalah salah satu alat di antara banyak indikator kesehatan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan masyarakat agrikultural, data *Body Mass Index* (BMI) sebaiknya dikombinasikan dengan indikator lain seperti status anemia, tingkat aktivitas fisik, dan konsumsi makanan harian. Pendekatan

multidimensional ini akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk intervensi kesehatan yang efektif.

Body Mass Index (BMI) juga menjadi alat yang bermanfaat untuk mempelajari hubungan antara status gizi dengan produktivitas kerja di sektor agrikultural (Yusuf & Rahmawati, 2019). Studi menunjukkan bahwa pekerja agrikultural dengan *Body Mass Index* (BMI) yang terlalu rendah sering kali mengalami penurunan kapasitas kerja, yang berdampak negatif pada hasil panen dan pendapatan. Di sisi lain, obesitas juga dapat memengaruhi produktivitas karena peningkatan risiko masalah kesehatan seperti nyeri sendi atau penyakit kronis (Nurjannah & Setiawan, 2018). Dengan demikian, menjaga *Body Mass Index* (BMI) dalam rentang normal bukan hanya penting untuk kesehatan individu tetapi juga untuk keberlanjutan sektor agrikultural. Sebagai kesimpulan, *Body Mass Index* (BMI) memiliki peran penting sebagai indikator kesehatan masyarakat agrikultural. Sederhana, murah, dan efektif, *Body Mass Index* (BMI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah kekurangan atau kelebihan gizi, memantau tren kesehatan, serta merancang rencana yang sesuai.

B. Penerapan *Health Self-Empowerment* (HSE) untuk Manajemen Berat Badan dan Keseimbangan Gizi

Masyarakat agrikultural, yang umumnya hidup dengan mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber utama pendapatan dan konsumsi, menghadapi aktivitas fisik yang intens, seperti

bercocok tanam, memanen, atau memelihara hewan ternak, sering kali membutuhkan energi yang besar. Namun, konsumsi makanan masyarakat agrikultural sering kali lebih bergantung pada ketersediaan pangan lokal dibandingkan pada keseimbangan kandungan nutrisi. Misalnya, pola makan yang tinggi karbohidrat dari nasi, jagung, atau ubi kayu sering kali tidak diimbangi dengan asupan protein, vitamin, dan mineral yang cukup. *Health Self-Empowerment* (HSE) membantu individu untuk memahami pentingnya aturan makanan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Langkah pertama penerapan *Health Self-Empowerment* (HSE) adalah edukasi berbasis komunitas. Edukasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat secara aktif (McKenzie, Neiger, & Thackeray, 2022). Mereka diberikan informasi mengenai pentingnya pola makan seimbang, kebutuhan kalori harian, serta cara sederhana untuk mengukur kecukupan gizi. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk mengenali kebutuhan tubuh mereka berdasarkan jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik. Dengan begitu, masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan makan yang lebih sehat tanpa meninggalkan kebiasaan konsumsi pangan lokal.

Pendekatan kedua adalah pelibatan teknologi sederhana untuk mendukung perubahan perilaku. Penggunaan alat sederhana, seperti bagan gizi, catatan harian makanan, atau aplikasi seluler berbasis komunitas, dapat membantu masyarakat mencatat

konsumsi makanan harian mereka. Dengan memanfaatkan teknologi ini, masyarakat dapat memahami pola makan mereka secara lebih jelas dan membuat penyesuaian yang diperlukan (Winata & Suryani, 2020). Pendampingan oleh petugas kesehatan atau relawan lokal juga penting untuk memastikan penerapan alat-alat ini berjalan dengan efektif.

Selain aspek gizi, manajemen berat badan menjadi fokus lain dalam *Health Self-Empowerment* (HSE). Di satu sisi, sebagian masyarakat agrikultural menghadapi masalah kekurangan berat badan akibat pola makan yang kurang seimbang. Di sisi lain, terdapat pula risiko obesitas pada individu yang mengonsumsi makanan tinggi kalori tetapi kurang aktif secara fisik di luar musim panen. *Health Self-Empowerment* (HSE) menekankan pentingnya pengaturan pola makan dan aktivitas fisik yang seimbang. Masyarakat agrikultural cenderung memiliki hubungan sosial yang erat, yang dapat dimanfaatkan untuk saling mendukung dalam menjaga kesehatan. Keberhasilan *Health Self-Empowerment* (HSE) sangat bergantung pada pendekatan yang terintegrasi, baik dari sisi pemerintah, petugas kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri.

C. Hubungan Antara Gaya Hidup Sehat dan Pengendalian BMI di Masyarakat Pertanian

Hubungan antara *Health Self-Empowerment* terhadap gaya hidup dan *Body Mass Index* (BMI) masyarakat di wilayah agrikultural menunjukkan

hubungan yang signifikan antara pola hidup sehat dengan pengendalian BMI. Masyarakat pertanian, yang cenderung menghadapi aktivitas fisik tinggi namun minim akses informasi kesehatan, sering kali mengalami tantangan dalam menjaga keseimbangan BMI mereka.

Implementasi model *Health Self-Empowerment* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya perilaku sehat, seperti pola makan bergizi, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan kebiasaan hidup bersih. Model ini memanfaatkan potensi lokal, seperti hasil pertanian, untuk mendukung asupan gizi yang lebih baik. Lebih dari separuh responden tidak memiliki pola makan teratur dan bergizi, aktivitas fisik yang cukup, maupun manajemen stres yang baik. Faktor-faktor ini berkorelasi dengan tingginya prevalensi BMI abnormal (overweight dan obesitas) pada masyarakat.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa intervensi berbasis *self-empowerment* mampu mengurangi risiko BMI abnormal dengan meningkatkan perilaku sehat. Sebagai contoh, intervensi ini membantu menurunkan prevalensi obesitas yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, yang sebagian besar terkait dengan perbedaan metabolisme lemak dan distribusi adiposa.

Pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan kesehatan berbasis teknologi, kolaborasi komunitas, serta dukungan pemerintah setempat untuk menciptakan perubahan gaya hidup

berkelanjutan di masyarakat agrikultural. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas dalam mendorong pengendalian BMI yang lebih baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 6

INTERVENSI *HEALTH SELF-EMPOWERMENT* UNTUK MASYARAKAT AGRIKULTURAL

A. Pendekatan Partisipatif dalam Program *Health Self-Empowerment* (HSE)

Pendekatan partisipatif telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan program *Health Self-Empowerment* (HSE), dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat bertujuan untuk memperkuat rasa memiliki, meningkatkan tingkat penerimaan, dan memastikan keberlanjutan program jangka panjang. Program *Health Self-Empowerment* (HSE) ini dirancang untuk memberdayakan individu agar dapat mengelola kesehatan secara mandiri, mengadopsi gaya hidup sehat, dan secara aktif memantau indikator kesehatan seperti *Body Mass Index* (BMI) (Fibriansari R. D., 2021). Hal ini penting karena *Body Mass Index* (BMI) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai status gizi dan risiko kesehatan seseorang. Di lingkungan agraris, sebagai contoh, masyarakat diundang untuk turut serta dalam penyusunan program. Dalam hal ini, potensi lokal seperti hasil pertanian digunakan untuk mendukung pola makan sehat yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan kesehatan yang interaktif dan relevan dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari (Dewi, The effectiveness of self-empowerment-based patient-centered care for obese students in primary services, 2023). Pendidikan ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun kesadaran kritis tentang pentingnya perubahan gaya hidup yang lebih sehat.

Pendekatan partisipatif memungkinkan *Health Self-Empowerment* (HSE) mengintegrasikan perspektif masyarakat ke dalam desain dan pelaksanaannya. Dengan memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat, program dapat lebih relevan dan efektif. Dalam konteks agraris, pendekatan ini menawarkan solusi yang tidak hanya berbasis kesehatan tetapi juga berorientasi pada lingkungan dan pekerjaan lokal. Sebagai contoh, hasil panen lokal seperti buah dan sayur yang tersedia dapat menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Selain itu, pekerjaan agraris yang membutuhkan tenaga fisik tinggi dapat diintegrasikan sebagai bentuk aktivitas fisik terstruktur, sehingga tidak hanya mendukung kesehatan tetapi juga produktivitas kerja. Lebih jauh lagi, pendekatan ini membantu mengatasi hambatan-hambatan psikososial yang sering kali menjadi penghalang perubahan perilaku kesehatan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya motivasi atau kepercayaan diri dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin

komunitas, program *Health Self-Empowerment* (HSE) mampu menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Keberadaan pemimpin lokal yang dihormati juga dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam program (Wippold & Frary, 2022).

Dampak positif dari pendekatan partisipatif juga terlihat pada penurunan prevalensi *Body Mass Index* (BMI) abnormal, seperti obesitas dan *underweight* (Vikawati, 2020). Program ini mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan berat badan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, program *Health Self-Empowerment* (HSE) berbasis komunitas menciptakan sinergi antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti penyuluh kesehatan, tenaga medis, dan pemerintah lokal. Dukungan lintas sektor ini memperkuat keberlanjutan program, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat terus berlanjut bahkan setelah program selesai dijalankan. Selain memberikan dampak langsung terhadap indikator kesehatan seperti *Body Mass Index* (BMI), pendekatan partisipatif dalam *Health Self-Empowerment* (HSE) juga membantu mengatasi hambatan unik yang dihadapi oleh masyarakat agraris (Priambodo, Dinata, & Hartati, 2020). Misalnya, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan sering kali menjadi penghalang utama dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat agraris. Program ini mengatasi hambatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi sederhana yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. Keterlibatan Tokoh Masyarakat, Penyuluh Pertanian, dan Pemerintah Lokal

Dalam pelaksanaan program *Health Self-Empowerment* (HSE), keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan. Tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, dan pemerintah lokal memegang peran strategis dalam membangun fondasi program yang kuat, memastikan relevansi dengan kebutuhan komunitas, serta menciptakan dampak jangka panjang yang positif.

1. Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat, yang umumnya memiliki pengaruh besar dan dihormati di lingkungannya, memainkan peran penting dalam menjembatani *Health Self-Empowerment* (HSE) dengan komunitas yang dilayani. Sebagai figur yang dipercaya, mereka mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas. Tokoh masyarakat berperan sebagai katalis perubahan, membantu menciptakan kesadaran mengenai pentingnya program *Health Self-Empowerment* (HSE), sekaligus membangun kepercayaan terhadap manfaatnya.

Melalui pendekatan personal, tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan moral yang kuat kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam program. Mereka juga sering menjadi pihak pertama yang masyarakat rujuk untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi terkait kegiatan program. Dengan menjadi

penghubung antara pelaksana program dan masyarakat, tokoh masyarakat membantu menciptakan dialog yang konstruktif, memfasilitasi penyelesaian masalah, dan memastikan bahwa masyarakat merasa didengar dan dilibatkan. Selain itu, peran tokoh masyarakat sangat vital dalam menciptakan rasa memiliki terhadap program *Health Self-Empowerment* (HSE). Ketika komunitas melihat tokoh yang mereka hormati mendukung program tersebut, kepercayaan terhadap program meningkat. Hal ini penting untuk membangun keterlibatan yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses implementasi program.

2. Kontribusi Penyuluh Pertanian

Di wilayah agraris, penyuluh pertanian memiliki hubungan yang erat dan intensif dengan masyarakat. Posisi strategis ini menjadikan mereka agen perubahan yang efektif dalam mendukung pelaksanaan program *Health Self-Empowerment* (HSE). Penyuluh pertanian dapat memanfaatkan hubungan baik mereka dengan petani untuk mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam aktivitas penyuluhan agrikultur sehari-hari.

Salah satu kontribusi signifikan penyuluh pertanian dalam program *Health Self-Empowerment* (HSE) merupakan edukasi tentang hubungan antara hasil pertanian, nutrisi, dan kesehatan. Sebagai contoh, mereka dapat membantu masyarakat memahami cara memanfaatkan hasil pertanian lokal untuk

mendukung pola makan yang sehat. Penyuluh tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi komunitas agraris.

Penyuluh pertanian juga memainkan peran dalam memperkenalkan inovasi teknologi yang dapat membantu masyarakat memantau dan meningkatkan kesehatan mereka. Misalnya, penyuluh dapat mengedukasi masyarakat tentang penggunaan aplikasi kesehatan sederhana yang dirancang khusus untuk komunitas agraris. Hal ini mendukung terciptanya sinergi antara kebutuhan ekonomi dan upaya peningkatan kesehatan, menjadikan program lebih relevan dan praktis untuk dijalankan. Dengan keahlian teknis mereka, penyuluh pertanian juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam menerapkan strategi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program. Sebagai pihak yang memahami kebutuhan lokal, mereka dapat memberikan masukan berharga kepada pelaksana program tentang intervensi yang paling sesuai untuk diterapkan di komunitas tertentu.

3. Dukungan Pemerintah Lokal

Keterlibatan pemerintah lokal menjadi elemen kunci dalam menyediakan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan program *Health Self-Empowerment* (HSE). Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan program. Salah satu kontribusi utama pemerintah adalah menyediakan dukungan

kebijakan yang jelas dan terarah. Hal ini mencakup regulasi tentang akses informasi kesehatan, promosi gaya hidup sehat, atau pengelolaan gizi berbasis komunitas.

Pemerintah lokal juga memiliki peran dalam menyediakan pendanaan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan program *Health Self-Empowerment* (HSE). Dengan dukungan anggaran, pelaksana program dapat menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat, mencetak dan mendistribusikan materi edukasi, serta mengembangkan infrastruktur kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah lokal dapat mendukung penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan program, seperti pengadaan perangkat teknologi kesehatan sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah lokal dan pelaksana program juga memungkinkan terciptanya kebijakan yang mendukung keberlanjutan program. Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok pendukung masyarakat yang bertujuan untuk melanjutkan inisiatif kesehatan setelah program berakhir. Selain itu, keterlibatan pemerintah membuka peluang untuk replikasi dan perluasan program ke wilayah lain. Dengan begitu, dampak positif dari program *Health Self-Empowerment* (HSE) dapat dirasakan oleh lebih banyak komunitas.

4. Kolaborasi dan Sinergi

Sinergi antara tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, dan pemerintah lokal menciptakan pendekatan holistik dalam pelaksanaan *Health Self-Empowerment* (HSE). Masing-masing pihak membawa keahlian dan pengaruhnya sendiri, yang bersama-sama memperkuat pelaksanaan program. Tokoh masyarakat memberikan dukungan sosial dan membangun kepercayaan, penyuluh pertanian menyumbangkan pengetahuan teknis dan hubungan dekat dengan komunitas agraris, sementara pemerintah lokal menyediakan kebijakan, pendanaan, dan fasilitas yang mendukung.

Kolaborasi ini memastikan bahwa program *Health Self-Empowerment* (HSE) tidak hanya fokus pada aspek kesehatan individu tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, program menjadi lebih relevan, diterima dengan baik, dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih besar. Sebagai contoh, di komunitas agraris, keterlibatan ketiga pihak ini memungkinkan terciptanya pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kesehatan. Tokoh masyarakat dapat memotivasi komunitas untuk mengadopsi gaya hidup sehat, penyuluh pertanian dapat memberikan edukasi tentang nutrisi dan aktivitas fisik, sementara pemerintah lokal dapat mendukung infrastruktur yang diperlukan, seperti pusat kesehatan komunitas atau aplikasi pemantauan kesehatan berbasis teknologi.

C. Implementasi Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) telah menjadi komponen kunci dalam mendukung implementasi program *Health Self-Empowerment* (HSE), terutama dalam era digital saat ini. Menurut Molleman (2001), melalui integrasi teknologi, individu dan komunitas dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan, memantau kondisi tubuh secara mandiri, dan mengambil langkah-langkah berdasarkan data yang diperoleh. TI membantu menjembatani kesenjangan dalam akses kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Salah satu bentuk implementasi TI dalam program *Health Self-Empowerment* (HSE) adalah pengembangan aplikasi kesehatan berbasis *mobile* (Dewi, Sekartini, & Sunardi, 2023). Aplikasi ini dirancang untuk memberikan edukasi kesehatan, panduan gaya hidup sehat, dan alat pemantauan indikator kesehatan seperti *Body Mass Index* (BMI), kadar gula darah, dan tekanan darah. Melalui fitur interaktif, pengguna dapat memasukkan data mereka, yang kemudian dianalisis oleh sistem untuk memberikan rekomendasi personal. Selain itu, aplikasi ini dapat mengingatkan pengguna untuk melakukan aktivitas sehat seperti olahraga, minum air yang cukup, atau mengatur pola tidur (Tucker, Roncoroni, & Wippold, 2018).

Selain aplikasi *mobile*, platform berbasis web juga berperan penting dalam mendukung program

Health Self-Empowerment (HSE). Situs web yang menyediakan informasi kesehatan terpercaya dan layanan konsultasi daring memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan edukasi kesehatan yang berkualitas tanpa perlu bertatap muka dengan tenaga kesehatan. Platform ini sering kali dilengkapi dengan forum komunitas, di mana pengguna dapat berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam menjalankan program kesehatan mereka. Teknologi *wearable* juga menjadi bagian integral dalam mendukung *Health Self-Empowerment* (HSE). Perangkat seperti gelang pintar atau jam tangan pintar dapat memantau berbagai indikator kesehatan secara real-time, termasuk detak jantung, jumlah langkah, dan tingkat aktivitas fisik harian. Data yang dikumpulkan oleh perangkat ini dapat disinkronkan dengan aplikasi atau platform *Health Self-Empowerment* (HSE) memberikan pengguna wawasan yang lebih dalam tentang kondisi kesehatan mereka. Dengan demikian, pengguna dapat mengambil langkah pencegahan sebelum masalah kesehatan menjadi serius.

Keunggulan utama TI dalam *Health Self-Empowerment* (HSE) adalah kemampuannya untuk menyediakan data yang akurat dan relevan secara cepat. Data ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam mendukung program ini. Misalnya, data yang terkumpul melalui aplikasi atau perangkat *wearable* dapat digunakan untuk menganalisis tren kesehatan komunitas dan merancang intervensi yang lebih efektif. Dalam konteks ini, TI juga membantu

meningkatkan efisiensi dan efektivitas program HSE secara keseluruhan.

Namun, implementasi TI dalam *Health Self-Empowerment* (HSE) juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, terutama di daerah rural atau terpencil. Masalah literasi digital juga menjadi hambatan, di mana tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, program HSE perlu dilengkapi dengan pelatihan literasi digital dan pengadaan infrastruktur teknologi yang memadai. Implementasi teknologi informasi dalam program *Health Self-Empowerment* (HSE) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat (Budury, Nurjanah, & Ainiyah, 2020). Dengan mendukung pemberdayaan diri melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi dan alat pemantauan kesehatan, TI tidak hanya membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat tetapi juga lebih berdaya dalam mengelola kesehatan mereka. Ke depan, pengembangan teknologi berbasis kebutuhan lokal akan menjadi kunci keberhasilan program *Health Self-Empowerment* (HSE) berbasis TI.

BAB 7

IMPLEMENTASI *HEALTH SELF-EMPOWERMENT* DI AREA PERTANIAN

A. Intervensi *Health Self-Empowerment* (HSE) dalam Masyarakat Agrikultural

Pengembangan model *Health Self-Empowerment* (HSE) yang diterapkan dalam masyarakat di wilayah agrikultural, dapat meningkatkan pemberdayaan individu untuk mengelola kesehatan mereka melalui pola hidup sehat yang mencakup pola makan, aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pengawasan *Body Mass Index* (BMI).

Pendekatan model *Health Self-Empowerment* (HSE) didasarkan pada prinsip-prinsip empowerment, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perubahan gaya hidup, dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta dukungan teknologi informasi. Program ini juga menggunakan elemen-elemen dari teori kesehatan seperti *Health Belief Model* dan *Social Cognitive Theory* untuk memprediksi perilaku individu yang mendukung kesehatan. Dengan hasil utama,

Dominasi laki-laki dalam profesi petani lebih menonjol, dengan keterlibatan yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam penelitian terkait gaya hidup atau kebiasaan kesehatan. Faktor budaya

dan peran gender dalam masyarakat agrikultural turut memengaruhi kecenderungan ini, di mana perempuan cenderung lebih banyak menjalankan tugas rumah tangga atau peran domestik lainnya. Dalam banyak komunitas agrikultural, pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas. Laki-laki umumnya terlibat langsung dalam aktivitas lapangan seperti bertani atau mengelola lahan, sedangkan perempuan lebih fokus pada urusan domestik. Pola peran tersebut berdampak pada keterlibatan mereka dalam penelitian yang membahas gaya hidup atau kebiasaan kesehatan.

Sebagian besar masyarakat agrikultural memiliki kategori IMT normal, yaitu 51,3% pada laki-laki dan 67,7% pada perempuan. Selain itu, hasil studi ini juga menemukan bahwa 55 responden (20,4%) tergolong overweight, sedangkan 27 responden (10%) mengalami obesitas. Kasus overweight dan obesitas paling banyak ditemukan pada kelompok usia 60–69 tahun.

Sebagian besar masyarakat agrikultural belum menjalani gaya hidup sehat. Dari total responden, 152 orang (57%) tidak menjaga pola makan teratur dan bergizi, 53 orang (20%) kurang memenuhi kebutuhan cairan harian, 86 orang (32%) tidak rutin beraktivitas fisik, dan 75 orang (28%) belum mencukupi waktu istirahat. Selain itu, 16 responden (6%) belum menerapkan pola hidup bersih, 156 orang (58%) mengalami kesulitan dalam mengelola stres, 99 orang (37%) jarang melakukan pemeriksaan

kesehatan rutin, dan 8 responden (3%) masih jarang melaksanakan ibadah.

B. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Model *Health Self-Empowerment* (HSE)

Untuk upaya meningkatkan efektivitas model *Health Self-Empowerment* (HSE) di masyarakat agrikultural, penyesuaian program berdasarkan kebutuhan lokal menjadi langkah awal yang krusial. Identifikasi kebutuhan ini dapat dilakukan melalui survei awal untuk memahami faktor budaya, kebiasaan hidup, serta tantangan kesehatan yang unik di masyarakat pertanian. Misalnya, masyarakat agrikultural sering kali memiliki aktivitas fisik tinggi, tetapi tidak disertai pola makan yang seimbang atau informasi memadai tentang gaya hidup sehat. Oleh karena itu, program *Health Self-Empowerment* (HSE) harus dirancang secara kontekstual dengan memperhatikan aspek-aspek seperti tradisi makan, pola kerja, dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas merupakan kunci dalam menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif. Hubungan ini dapat diperkuat melalui pendekatan personal, melibatkan tokoh masyarakat, dan penyuluh kesehatan setempat yang sudah dikenal oleh warga.

Penting juga untuk menerapkan evaluasi yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari program. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* yang tidak hanya mengukur efektivitas intervensi tetapi juga mengidentifikasi area yang memerlukan

perbaikan. Selain itu, mendengarkan masukan dari masyarakat menjadi cara penting untuk menyempurnakan program agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memberikan ruang bagi komunitas untuk berbagi pengalaman dan tantangan, program HSE dapat disesuaikan secara dinamis, sehingga meningkatkan relevansi dan keberhasilan implementasinya.



Gambar 8.1: Media Edukasi

Strategi lain yang perlu diterapkan adalah pendekatan berbasis psikologis untuk mendorong keberlanjutan perubahan perilaku. Aspek seperti *self-efficacy* atau keyakinan diri seseorang dalam mengelola kesehatan sangat penting untuk

dikembangkan. Intervensi dapat mencakup pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen kesehatan pribadi, seperti membuat rencana makan sehat, melatih aktivitas fisik teratur, dan mengelola stres. Selain itu, penerapan *self-praise*, yakni penguatan diri dengan memberi penghargaan atas pencapaian kecil dalam perjalanan kesehatan, dapat membantu individu merasa lebih termotivasi. Dengan membangun kepercayaan diri individu melalui elemen-elemen psikologis ini, perubahan gaya hidup sehat cenderung lebih berkelanjutan.

Penghargaan eksternal juga memainkan peran penting dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program. Memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang menunjukkan perubahan positif, seperti penurunan *Body Mass Index* (BMI) atau peningkatan perilaku sehat, dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan keterlibatan. Penghargaan ini tidak harus berupa hadiah fisik tetapi bisa berupa pengakuan, seperti sertifikat penghargaan atau apresiasi publik yang diberikan dalam acara komunitas. Dengan cara ini, masyarakat merasa dihargai atas usaha mereka dan termotivasi untuk terus mempertahankan perubahan yang telah mereka capai.

Teknologi informasi juga dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan efektivitas model *Health Self-Empowerment* (HSE). Dalam masyarakat modern, bahkan di daerah agrikultural, penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dapat membantu memberikan informasi kesehatan yang mudah

diakses. Aplikasi ini dapat dirancang untuk menyediakan panduan tentang pola makan sehat, pengingat untuk aktivitas fisik, dan alat pemantauan *Body Mass Index* (BMI). Selain itu, perangkat wearable seperti gelang kebugaran dapat digunakan untuk memantau aktivitas harian dan memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mereka, tetapi juga memberikan rasa kontrol yang lebih besar terhadap upaya menjaga kesehatan. Untuk mendukung ini, pelatihan penggunaan teknologi harus disediakan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan alat-alat ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kelompok usia.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga merupakan strategi penting. Pemerintah daerah, institusi kesehatan, dan sektor swasta harus dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan program *Health Self-Empowerment* (HSE). Pemerintah dapat menyediakan pendanaan dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program, seperti subsidi untuk alat pemantauan kesehatan atau pendidikan kesehatan gratis. Institusi kesehatan, seperti puskesmas, dapat memberikan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan konsultasi kesehatan. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pengadaan alat atau materi edukasi kesehatan. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, pelaksanaan

program dapat lebih terorganisasi dan memiliki cakupan yang lebih luas.

Selain pendekatan individual, pendekatan berbasis komunitas juga penting untuk diterapkan. Program dapat diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan komunitas yang sudah ada, seperti pertemuan kelompok tani atau kegiatan posyandu. Dengan cara ini, program tidak hanya memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada tetapi juga memberikan kesan bahwa program ini adalah bagian dari kegiatan rutin masyarakat, sehingga lebih mudah diterima. Pendekatan keluarga juga harus menjadi bagian dari strategi, karena dukungan dari keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan individu dalam menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya, melibatkan keluarga dalam pelatihan memasak sehat atau aktivitas fisik bersama dapat menciptakan lingkungan pendukung yang memperkuat perubahan perilaku individu.

Dalam penerapan strategi-strategi ini, penting untuk selalu memperhatikan keberlanjutan program. Salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki program tersebut dan termotivasi untuk menjaganya tetap berjalan meskipun dukungan eksternal telah berkurang. Selain itu, pelatihan kepada kader kesehatan lokal dapat menjadi solusi untuk memastikan program terus berlanjut. Kader ini dapat berfungsi sebagai pendamping masyarakat dalam mengimplementasikan perubahan gaya hidup

sehat serta sebagai penghubung antara masyarakat dan fasilitas kesehatan.

Pada akhirnya, efektivitas model *Health Self-Empowerment* (HSE) juga bergantung pada bagaimana program ini dirancang untuk menciptakan dampak yang nyata dan terukur. Salah satu indikator keberhasilan adalah penurunan prevalensi *Body Mass Index* (BMI) abnormal, seperti obesitas, di masyarakat. Selain itu, peningkatan perilaku sehat, seperti pola makan teratur, aktivitas fisik yang cukup, dan kemampuan mengelola stres, juga menjadi ukuran penting. Dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis komunitas, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, model *Health Self-Empowerment* (HSE) dapat memberikan perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat agrikultural.

BAB 8

PENUTUP

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki kaitan erat dengan gaya hidup serta indeks massa tubuh (BMI). Pola hidup yang sehat menjadi fondasi utama untuk mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental individu. Seiring berkembangnya pemahaman pada bidang kesehatan, konsep *self-empowerment* atau pemberdayaan diri semakin mendapatkan perhatian. Konsep ini berfokus pada pemberian kontrol kepada individu agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Model pemberdayaan diri ini sangat relevan terutama untuk masyarakat yang menghadapi tantangan unik, seperti komunitas agrikultural.

Masyarakat di daerah pertanian sering kali menghadapi pekerjaan fisik yang berat dan memiliki akses terbatas terhadap informasi kesehatan. Oleh karena itu, penerapan model *Health Self-Empowerment* (HSE) menjadi inovasi penting untuk membantu komunitas ini meningkatkan kualitas hidup mereka. *Health Self-Empowerment* (HSE) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana gaya hidup sehat dapat memengaruhi kesehatan mereka, termasuk dalam mengelola *Body Mass Index* (BMI).

Mayoritas Masyarakat agrikultural yang terlibat dalam kegiatan edukasi kesehatan adalah perempuan (88%), sedangkan laki-laki hanya berjumlah 12%. Temuan

ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering terlibat dalam kegiatan edukasi kesehatan di daerah agrikultural. Dalam hal *Body Mass Index* (BMI), kategori abnormal pada perempuan ternyata lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebanyak 34 perempuan (8%) tercatat memiliki BMI dalam kategori overweight, sementara pada laki-laki hanya 6 orang (2%) yang masuk dalam kategori ini. Selain itu, obesitas juga lebih banyak ditemukan pada perempuan, dengan 70 orang (26%) dibandingkan 10 laki-laki (3%). Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh variasi metabolisme lemak antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis, perempuan cenderung memiliki lemak tubuh yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Lemak tubuh perempuan juga lebih banyak terkonsentrasi di area *gluteofemoral*, seperti pinggul dan paha, yang merupakan karakteristik alami tubuh perempuan. Sebaliknya, laki-laki lebih rentan terhadap penumpukan lemak di area perut, kondisi yang dikenal dengan obesitas sentral. Perbedaan ini memberikan implikasi penting dalam *Body Mass Index* (BMI), di mana pendekatan berbasis gender mungkin diperlukan untuk memberikan intervensi yang lebih efektif.

Model health self-empowerment menawarkan pendekatan holistik untuk membantu masyarakat mengelola *Body Mass Index* (BMI) mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, pola makan yang seimbang, dan aktivitas fisik yang cukup, individu dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan intensif di kalangan perempuan, mengingat tingginya prevalensi *Body Mass Index* (BMI) abnormal di kelompok ini. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan

komunitas agrikultural dapat membantu masyarakat mengatasi tantangan yang mereka hadapi, seperti kurangnya waktu luang atau akses terhadap makanan sehat.

Pentingnya penerapan model *Health Self-Empowerment* (HSE) sebagai pendekatan inovatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agrikultural. Dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan perbedaan gender dalam metabolisme lemak, program-program berbasis *Health Self-Empowerment* (HSE) dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Lebih jauh, pendidikan kesehatan yang berkelanjutan, dukungan komunitas, dan intervensi berbasis teknologi dapat membantu memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2016). Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi pada Petani. *Media Gizi Indonesia*, 10(2), 125-132.
- Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.
- Bandura, A. (2021). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. California: Stanford University Press.
- Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2004). *Handbook of Self-Regulation: Research, Theory, and Applications*. New York, USA: Guilford Press.
- Bravo, P., Edwards, A., Barr, P. J., Scholl, I., Elwyn, G., McAllister, M., et al. (2021). Conceptualizing patient empowerment: A mixed-methods study. *Patient Education and Counseling*, 104(1), 68-75.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. United States of America: Harvard University Press.
- Budury, S., Nurjanah, S., & Ainiyah, N. (2020). Implementing lifestyle management using health promotion model approach. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(2), 537-541.
- Davis, S., & Jones, M. (2021). Agricultural workers' health and safety: Developing health self-empowerment strategies for rural populations. *Journal of Rural Health*, 37(4), 687-695.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Springer.
- Dewi, D. K. (2023). The effectiveness of self-empowerment-based patient-centered care for

- obese students in primary services. *Journal of Family & Community Medicine*.
- Dewi, D. K., Sekartini, R., & Sunardi, D. (2023). The effectiveness of self-empowerment-based patient-centered care for obese students in primary services: A randomized controlled trial. *Journal of Family & Community Medicine*, 30(1), 51.
- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Manattan, Amerika Serikat: Random House.
- Fibriansari, R. D. (2020). Development of a Health Self-Empowerment Model for Community Lifestyle and Body Mass Index (BMI) in Agricultural Areas. *Jurnal NERS*.
- Fibriansari, R. D. (2021). Strategi Empowerment Pada Lingkungan Kerja Keperawatan. *Thesis Commons 4cavd, Center for Open Science*.
- Fumagalli, L. P., Radaelli, G., Lettieri, E., Bertele', P., & Masella, C. (2020). Patient Empowerment and its impact on health outcomes: A systematic review. *Healthcare*, 8(1), 15.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach*. Sydney: McGraw-Hill.
- Gutiérrez, L. M. (1995). Understanding the Empowerment Process: Does Consciousness Make a Difference. *Social Work Research*, 19(4), 229–237.
- Hardinsyah. (2017). *Gizi dan Kesehatan di Indonesia: Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Pangan*. Jakarta: Pergizi Pangan Indonesia.

- Hardinsyah, D. (2009). Peran Gizi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Produktivitas. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 20(4), 258-268.
- Hartono, B., & Yulianto, E. (2022). Kesehatan Mental Petani di Tengah Ketidakpastian Ekonomi. *Jurnal Sosial Pedesaan*.
- House, J. S., Umberson, D., & Landis, K. R. (1988). Structures and Processes of Social Support. *Annual Review of Sociology*, 14, 293-318.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Kementerian Pertanian. (2022, Agustus 10). *Pemasyarakatan Penggunaan Pestisida Nabati Dalam Mendukung Perlindungan Tanaman Perkebunan*. Retrieved November 15, 2024, from Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan:
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/pemasyarakatan-penggunaan-pestisida-nabati-dalam-mendukung-perindungan-tanaman-perkebunan/>
- Khomsan, A. (2004). Gizi dan Produktivitas Kerja. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 2(1), 49-54.
- Lambert, J., & Loiselle, C. (2007). Health information-seeking behavior. *Qualitative Health Research*, 17(8), 1006-1019.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company.
- Lupton, D. (2021). *The Quantified Self: Technology, Health and Society*. Oxfordshire, Inggris: Routledge.

- McKenzie, J. F., Neiger, B. L., & Thackeray, R. (2022). *Planning, Implementing, and Evaluating Health Promotion Programs*. London, Inggris: Pearson.
- Ministry of Health Indonesia. (2020). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Molleman, E., Van Delft, B., & Slomp, J. (2001). The application of an empowerment model. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing*, 11(4), 339–354.
- National Institute of Health. (1998). *Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults*. Bethesda: NIH.
- Neuman, B. (1982). *The Neuman Systems Model: Application to Nursing Education and Practice*. New York: Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts.
- Nilsen, P., Roback, K., Broström, A., & Ellström, P. E. (2019). Implementing evidence-based practice in human service organizations: A literature review of the challenges and the frameworks. *Implementation Science*, 15(4), 56-67.
- Nurjannah, A., & Setiawan, A. (2018). Transformasi Pola Makan dan Dampaknya terhadap Status Gizi Petani di Wilayah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Pangan dan Gizi*, 9(1), 56-64.
- Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. *Social Science & Medicine*, 67(12), 2072-2078.
- Nutbeam, D., Harris, E., & Wise, M. (2010). *Health Promotion: Strategies and Methods*. NSW: McGraw-Hill: Sydney.

- Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2019). *Health Promotion in Nursing Practice*. Canada: Pearson.
- Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise and Well-Being: A Review of Mental and Physical Health Benefits Associated with Physical Activity. *Current Opinion in Psychiatry*, 18(2), 189–193.
- Pranata, S., Pratiwi, N. L., & Rahanto, S. (2011). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan, Gambaran Peran Kader Posyadu dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di kota Manado Palangkaraya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan*, Vol 14, No 2, 175-182.
- Priambodo, A., Dinata, V. C., & Hartati, S. C. (2020). Healthy Lifestyle Physical Education Teachers Based on Physical Activity and Body Mass Index. *International Journal of Creative Arts and Humanities*, 491, 1093–1097.
- Prihatini, S., & Febry, F. (2017). Distribusi Status Gizi Berdasarkan BMI pada Penduduk Dewasa di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 16(2), 78-85.
- Purnamasari, K. (2018). Tantangan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil: Studi Kasus Masyarakat Pedesaan. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 13(2), 78-85.
- Purnomo, T. (2019). Risiko Kesehatan Petani Akibat Paparan Pestisida di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(2), 123-130.

- Rosenstock, I. (1974). Historical Origins of the Health Belief Model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328-335.
- Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (2020). The Health Belief Model and Health Behavior. In K. Glanz, B. K. Rimer, & K. V. (Eds.), *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (5th ed)* (pp. 45-65). New Jersey: Jossey-Bass.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why Zebras Don't Get Ulcers*. New York City: Henry Holt and Company.
- Schwarzer, R. (1992). *Self-Efficacy: Thought Control of Action*. Washington, DC: Hemisphere.
- Suhartono, E. (2016). Budaya Gotong Royong di Pedesaan dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan Indonesia*, 11(1), 29-42.
- Sukandar, D., Khomsan, A., & Riyadi, H. (2009). Gambaran Status Gizi Petani dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 6(1), 45-54.
- Suryani, N., & Hadi, S. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas dalam Kesehatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 101-112.

- Suryowati, E., & Rochmah, N. (2015). Prevalensi Obesitas dan Faktor Risiko pada Komunitas Agrikultural di Daerah Suburban Jawa Timur. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 43(3), 234-241.
- Sutrisno, A. (2020). Cedera Muskuloskeletal pada Pekerja Pertanian di Pedesaan Jawa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Tucker, C. M., Roncoroni, J., & Wippold, G. M. (2018). Health Self-Empowerment Theory: Predicting health behaviors and BMI in culturally diverse adults. *Family & Community Health*, 41(3).
- Vikawati, N. E. (2020). Physical Activity Correlates to Body Mass Index among Medical Students. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*.
- Whitehead, M., & Dahlgren, G. (2020). Concepts and principles for tackling social inequities in health. *World Health Organization*, 1.
- Winata, E., & Suryani, T. (2020). Pendekatan Partisipatif dalam Peningkatan Gizi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 120-130.
- Wippold, G. M., & Frary, S. G. (2022). The role of modifiable, self-empowerment-oriented variables to promote health-related quality of life. *Journal of Prevention*.
- World Health Organization (WHO). (2004). *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2024, Juni 26). *Physical inactivity: A global public health problem*. Retrieved November 15, 2024, from World Health

Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

Yusuf, M., & Rahmawati, A. (2019). Aktivitas Fisik dan Status Gizi pada Pekerja Agrikultural di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13(4), 205-212.

Zimmerman, M. A. (2020). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. P. (Ed.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43-63). Boston: Springer.

GLOSARIUM

A

Agrikultural : Terkait dengan pertanian, melibatkan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada aktivitas bertani untuk mata pencaharian.

Adipose Tissue : Jaringan lemak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi dan pelindung organ tubuh, dengan distribusi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

B

BMI (Body Mass Index) : Indeks Massa Tubuh, suatu pengukuran yang digunakan untuk menentukan status berat badan seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan.

G

Gluteofemoral Region: Area tubuh di sekitar pinggul dan paha, tempat penyimpanan lemak tubuh yang dominan pada perempuan.

H

Health Self-Empowerment (HSE) : Model pemberdayaan diri dalam kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif individu dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri melalui pola hidup sehat.

I

Intervensi : Tindakan atau program yang dirancang untuk mengubah atau memengaruhi perilaku atau kondisi tertentu dalam populasi penelitian.

M

Metabolisme Lemak : Proses biologis dalam tubuh yang melibatkan pemecahan dan penyimpanan lemak sebagai sumber energi.

O

Obesitas : Kondisi kelebihan berat badan yang ekstrem, ditandai dengan indeks massa tubuh yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis.

Obesitas Sentral : Penumpukan lemak di area perut, yang sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan penyakit jantung.

Overweight : Kondisi ketika indeks massa tubuh seseorang berada di atas kisaran normal tetapi belum mencapai kategori obesitas.

P

Pola Hidup Sehat : Kebiasaan sehari-hari yang mencakup pola makan, aktivitas fisik, istirahat cukup, dan pengelolaan stres untuk menjaga kesehatan.

Prevalensi : Proporsi jumlah kasus tertentu dalam populasi tertentu pada waktu tertentu.

Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan kesehatan dasar di Indonesia.

S

Self-Efficacy : Keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam mengelola kesehatan.

Self-Empowerment : Konsep pemberdayaan diri yang fokus pada peningkatan kemampuan individu untuk mengontrol dan membuat keputusan terkait aspek-aspek kehidupannya, termasuk kesehatan.

PROFIL PENULIS



Ns. Rizeki Dwi Fibriansari, S.Kep., M.Kep. lahir di Lumajang, 11 Februari 1987 adalah staf pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Jember sejak tahun 2017. Penulis menempuh pendidikan S1 dan S2 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun

2010 dan saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizekifibriansari@unej.ac.id



Ns. Nurfika Asmaningrum, S.Kep., M.Kep., Ph.D lahir di Jombang, 12 Januari 1980 adalah staf pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Jember sejak tahun 2009. Penulis menempuh pendidikan doktoral di Chang Gung University, Taiwan tahun 2019. Saat ini penulis mengampu mata

kuliah Kebutuhan Dasar Manusia dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurfika_asmaningrum@unej.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Anggia Astuti, S.Kp, M.Kep. lahir di Blitar, 26 Januari 1984 adalah staf pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Jember sejak tahun 2012. Penulis menempuh pendidikan S1 STIKES Binawan Jakarta dan S2 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anggiastuti.oi26@unej.ac.id

SINOPSIS BUKU

Buku ini menawarkan panduan holistik untuk mengadopsi konsep *Health Self-Empowerment* (HSE) dalam mengelola kesehatan pribadi dan komunitas, khususnya di masyarakat agrikultural. Dengan menggunakan pendekatan berbasis teori, buku ini menyoroti pentingnya pemberdayaan individu untuk mengelola kesehatan melalui pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri. Penulis menjelaskan bagaimana masyarakat agrikultural, yang sering kali menghadapi tantangan seperti paparan pestisida dan akses terbatas ke layanan kesehatan, dapat memanfaatkan HSE untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Buku ini mencakup strategi praktis seperti pengelolaan gaya hidup sehat, literasi kesehatan, penggunaan teknologi, dan penguatan dukungan sosial untuk mendorong kemandirian dalam perawatan kesehatan.

Dengan bahasa yang sederhana, buku ini juga menyajikan studi kasus dan implementasi HSE yang berhasil dalam komunitas agrikultural. Pesan utamanya adalah bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama yang dapat dicapai dengan perubahan perilaku sederhana dan kolaborasi komunitas. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum untuk mengintegrasikan pendekatan holistik dalam mencegah penyakit tidak menular dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat serta produktif.

Buku ini menawarkan panduan holistik untuk mengadopsi konsep Health Self-Empowerment (HSE) dalam mengelola kesehatan pribadi dan komunitas, khususnya di masyarakat agrikultural. Dengan menggunakan pendekatan berbasis teori, buku ini menyoroti pentingnya pemberdayaan individu untuk mengelola kesehatan melalui pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri. Penulis menjelaskan bagaimana masyarakat agrikultural, yang sering kali menghadapi tantangan seperti paparan pestisida dan akses terbatas ke layanan kesehatan, dapat memanfaatkan HSE untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Buku ini mencakup strategi praktis seperti pengelolaan gaya hidup sehat, literasi kesehatan, penggunaan teknologi, dan penguatan dukungan sosial untuk mendorong kemandirian dalam perawatan kesehatan.

Dengan bahasa yang sederhana, buku ini juga menyajikan studi kasus dan implementasi HSE yang berhasil dalam komunitas agrikultural. Pesan utamanya adalah bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama yang dapat dicapai dengan perubahan perilaku sederhana dan kolaborasi komunitas. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum untuk mengintegrasikan pendekatan holistik dalam mencegah penyakit tidak menular dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat serta produktif.



Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

